Masterclass de Psiquiatria

Nov 8, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Como usar este material

Este documento condensa as 12 apostilas da pasta Psiquiatria (Aulas 1 a 13, de Mariana Freitas, turma 79A) em um único roteiro de estudo. O conteúdo segue fielmente os resumos e o DSM-5-TR (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, texto revisado), que é a diretriz citada nas próprias aulas. Nada foi acrescentado fora desse escopo; quando uma explicação de mecanismo aprofunda o texto original, ela apenas detalha a fisiologia ou a farmacologia já mencionada.

Cada aula está organizada na mesma ordem lógica, para que o raciocínio clínico se torne automático: conceito, epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, critérios diagnósticos, diagnóstico diferencial e tratamento. Ao final de cada bloco há um mnemônico de fixação. A última seção reúne quadros comparativos de psicofármacos e os pontos que mais caem em prova.

Estratégia sugerida de estudo (método 3 passadas):

1. Primeira leitura corrida, apenas para entender a lógica de cada transtorno.
2. Segunda leitura focada nos critérios diagnósticos, nos tempos mínimos e nos mnemônicos.
3. Terceira passada só pela revisão final, tentando reconstruir de memória cada quadro antes de conferir.

Abreviações gerais usadas ao longo do texto:

Abreviação	Escrita por extenso
EEM	Exame do Estado Mental
QP	Queixa Principal
HMA	História da Moléstia Atual
DSM-5-TR	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, texto revisado
CID	Classificação Internacional de Doenças
SNC	Sistema Nervoso Central
ISRS	Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina

Abreviação	Escrita por extenso
IRSN	Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina
ADT	Antidepressivos Tricíclicos
IMAO	Inibidores da Monoaminoxidase
BZD	Benzodiazepínicos
TCC	Terapia Cognitivo Comportamental
ECT	Eletroconvulsoterapia
TEPT	Transtorno de Estresse Pós-Traumático
TOC	Transtorno Obsessivo Compulsivo
TAG	Transtorno de Ansiedade Generalizada
TAB	Transtorno Afetivo Bipolar
TDM	Transtorno Depressivo Maior
TDAH	Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
TEA	Transtorno do Espectro Autista
TCE	Traumatismo Cranioencefálico
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial

Abreviações específicas de cada tema aparecem explicadas entre parênteses na primeira vez em que surgem dentro da aula correspondente.

Aulas 1 e 2. Entrevista psiquiátrica e exame do estado mental

A entrevista é o principal instrumento diagnóstico da psiquiatria, e a qualidade da comunicação está diretamente relacionada ao sucesso do tratamento. Não existe exame laboratorial que substitua a observação clínica; por isso o EEM (Exame do Estado Mental) funciona como o "exame físico" do psiquismo.

1. Estrutura da consulta

Abertura e rapport (vínculo terapêutico). Apresente-se, identifique o acompanhante e estabeleça vínculo pela escuta ativa, que comunica acolhimento. O acompanhante é indispensável em crianças e idosos com déficit cognitivo; nos demais casos, respeite a vontade do paciente e observe sua expressão quando o acompanhante fala.

Roteiro da anamnese:

1. **Identificação completa.** Além dos dados, observe como o paciente responde a cada pergunta (escolaridade, estado civil): a reação emocional já é dado semiológico.
2. **QP (Queixa Principal) e HMA (História da Moléstia Atual).** Pergunte se é a primeira consulta psiquiátrica. Se for, pergunte o que o trouxe; a queixa real pode surgir apenas ao longo da conversa. Se não for, reconstrua desde o primeiro atendimento: motivos, cronologia dos sintomas e estado atual.
3. **Antecedentes psiquiátricos.** Tratamentos prévios com medicamento, dose, tempo de uso, efetividade e efeitos colaterais; internações; risco de vida, com destaque para tentativas de autoextermínio.
4. **História pessoal, familiar e genética, e história social.**
5. **EEM (Exame do Estado Mental).**

Mnemônico do roteiro: "I Quero Ajudar Pessoas Felizes Sempre Mentalmente" = Identificação, QP/HMA, Antecedentes, Pessoal, Familiar, Social, Mental (EEM).

2. Exame do Estado Mental: a sequência das funções

Mnemônico "A CO-A-ME-I-LI-HU-AF-PE-JU-SEN-VO-PSI", lido como "A Coisa Ama Mesmo Isso: Linguagem, Humor, Afeto, Pensamento, Juízo, Sensopercepção, Vontade e Psicomotricidade": Atitude, Consciência (e orientação), Atenção, Memória, Inteligência, Linguagem, Humor, Afeto, Pensamento, Juízo, Sensopercepção, Vontade, Psicomotricidade.

3. Consciência

Consciência é a função psíquica que permite perceber a si e ao ambiente, mantendo capacidade de resposta aos estímulos. Três conceitos precisam ficar separados:

Conceito	O que avalia	Exemplo
Nível (alerta)	Grau de vigília: alerta, sonolento, torporoso, coma	Acordado e responde quando chamado
Lucidez	Clareza e organização do pensamento	Fala coerente, orientado
Campo	Amplitude do conteúdo psíquico acessível no momento: normal, estreitado ou fragmentado	"Quanto da mente funciona ao mesmo tempo?"

Alerta não é o mesmo que lúcido. O paciente em delirium ou em surto psicótico está acordado, responde e conversa, mas diz "sei que vocês querem me matar, há câmeras na parede": alerta, porém não lúcido. Regra prática: alerta = acordado e responde; lúcido =

pensa de forma clara e coerente.

Alterações do campo de consciência:

- **Estreitamento simples.** Foco muito reduzido. Exemplo: crise de pânico, em que o paciente só consegue pensar que vai morrer.
- **Estado crepuscular (estreitamento patológico e transitório).** A pessoa está acordada e age de forma aparentemente organizada, com automatismos e atividade psicomotora preservada, mas sem integração consciente nem crítica, e depois apresenta amnésia lacunar do período. Causas: zolpidem (acorda, come, manda mensagens, dirige e não lembra), blackout alcoólico, intoxicações, epilepsia e TCE (Traumatismo Cranioencefálico).
- **Dissociação (fragmentação do campo).** Desconexão entre memória, identidade, percepção e emoção; funciona como defesa inconsciente para "desligar" de sofrimento intenso. Exemplos: "parecia que eu via tudo de fora do meu corpo" durante um acidente, amnésia traumática e hipnose (estado lúcido com alteração focal da consciência).
- **Delirium (alteração global de nível e conteúdo).** Quadro agudo ou subagudo, sempre secundário a causa orgânica intra ou extracraniana, nunca transtorno psiquiátrico primário. Tem déficit de atenção, flutuação ao longo do dia e inversão do ciclo sono e vigília, com piora noturna (sundowning). É emergência clínica: o tratamento é identificar e corrigir a causa. Exemplo clássico: idoso com infecção urinária que parece bem de dia e à noite fica agitado, não reconhece familiares e vê "gente no quarto".

Mnemônico do delirium: "AFOC" = Atenção prejudicada, Flutuação, Orgânico sempre, Ciclo sono e vigília invertido.

4. Consciência do eu

Capacidade de se reconhecer como ser vivo, único, indivisível e autor dos próprios atos e memórias. São cinco dimensões; **mnemônico "AEUIL" (A Eu Uso Imaginação Livre)**:

Dimensão	Normal	Alterado
Atividade (autoria)	"Eu decidi vir ao médico"	"Esses pensamentos não são meus; meu braço mexeu e não fui eu" (delírio de influência)
Existência	"Estou vivo, conversando"	"Acho que estou morto"
Unidade	"Penso, sinto e ajo; tudo sou eu"	"Há duas pessoas dentro de mim"

Dimensão	Normal	Alterado
Identidade (continuidade no tempo)	"Sou a mesma pessoa que estudou medicina"	"Essa vida não é minha"
Limite (eu e mundo)	"Meus pensamentos são só meus"	"Todos ouvem o que eu penso" (psicose)

5. Orientação

- **Autopsíquica ("quem sou eu?").** Liga-se à identidade; alterações sugerem mais quadro psiquiátrico primário ("eu sou um rei").
- **Alopsíquica (tempo, espaço e situação).** Alterações sugerem mais causa orgânica, como delirium e demência ("estamos em 1995", "estou em casa" estando internado).

Macete: AUTO = psiquiátrico; ALO = orgânico.

6. Atenção (prosexia)

É a direção da consciência: organiza o campo em figura (foco nítido) e fundo (periferia difusa). Avalia-se em dois eixos normalmente antagônicos:

- **Tenacidade:** manter o foco no tempo. Hipotenaz = perde o fio (ansiedade, TDAH, delirium). Hipertenaz = preso a um tema (obsessões, depressão, paranoia).
- **Vigilância:** deslocar o foco para novos estímulos. Hipovigil = "travado", continua respondendo à pergunta anterior. Hipervigil = distraível, qualquer ruído desvia.

Normalmente andam em pares opostos: hipotenaz com hipervigil, e hipertenaz com hipovigil. **As duas exceções que caem em prova:**

- **Hipoprosexia (depressão grave):** hipotenaz + hipovigil, com lentificação global.
- **Hiperprosexia (mania):** hipertenaz + hipervigil, com exaltação da energia psíquica.

Macete: na depressão tudo "hipo"; na mania tudo "hiper".

7. Memória

Três etapas: codificação (registro), armazenamento (manutenção) e evocação (recuperação). **Macete: "CAE".**

Tipos:

- **Imediata ou curto prazo:** dura menos de 2 minutos sem repetição, depende da atenção e é a porta de entrada para as demais (lembrar o nome de alguém recém apresentado).

- **De trabalho:** memória imediata com capacidade de operar a informação (contas de cabeça). É funcionalmente inseparável da atenção e sustenta raciocínio e planejamento.
- **Longo prazo declarativa (explícita, verbalizável):** episódica ou autobiográfica (uma viagem, com contexto temporal e emocional) e semântica (fatos; saber a data do próprio nascimento sem lembrar o evento é semântica). Na demência ambas se alteram, sobretudo a episódica no início.
- **Longo prazo não declarativa (implícita):** procedural (dirigir, andar de bicicleta) e priming (um estímulo prévio influencia a resposta sem que a pessoa perceba).

Alterações quantitativas:

- **Hipomnésia e amnésia.** Quanto ao tempo: anterógrada, quando não consolida memórias novas e preserva as antigas (Alzheimer inicial); retrógrada, quando perde o que veio antes do evento causal, afetando mais as recentes (TCE, crises epilépticas, trauma). Quanto à extensão: generalizada (grande parte da vida; quadros orgânicos graves ou dissociativos), lacunar (um período; blackout, epilepsia, TCE, estados crepusculares) e seletiva (conteúdo afetivamente carregado; mecanismo dissociativo).
- **Hipermnésia.** Fluxo de memória exagerado; ocorre após trauma (lembrança hiperconsolidada) e na mania.

Alterações qualitativas:

- **Alomnésia:** fato real lembrado de forma distorcida, por erro cronológico, amplificação emocional ou distorção de conteúdo.
- **Déjà-vu e jamais-vu:** sensação de já ter vivido o que é novo, ou de estranhar o familiar; ocorre em pessoas saudáveis e na epilepsia do lobo temporal.
- **Criptomnésia:** memória evocada como se fosse ideia original; é falha em identificar a origem da lembrança.
- **Confabulação:** lacuna preenchida com relato falso, sem intenção de mentir, e o paciente acredita no que diz ("fui trabalhar ontem", estando internado há dias). Típica de demências e síndrome de Korsakoff; ocorre em menor grau no TDAH e em qualquer pessoa desatenta.

8. Inteligência

Capacidade global de compreender, raciocinar, resolver problemas, adaptar-se e aprender, avaliada em comparação com a média esperada para idade, escolaridade e contexto. Nos séculos XIX e XX o foco era o QI (Quociente de Inteligência), centrado em lógica matemática e verbal, cuja validade clínica foi questionada porque QI alto não

garantia sucesso. Na década de 1980 surgiu a Teoria das Múltiplas Inteligências, que incluiu artes, relações interpessoais e autoconhecimento, além de cognição social, capacidade de abstração e inteligência emocional.

9. Linguagem

Alteração	Definição	Onde aparece
Logorreia ou verborragia	Fala excessiva, contínua, difícil de interromper	Mania
Taquilalia	Fala acelerada	Mania, com fuga de ideias
Bradilalia	Fala lenta, com latência aumentada	Depressão grave, bradipsiquismo
Mutismo	Ausência total de fala estando acordado	Catatonia, psicose grave, dissociação, neurológico
Mussitação	Murmúrio baixo, "fala para dentro"	Resposta a alucinações auditivas
Ecolalia	Repete a última palavra do outro	Catatonia, TEA (Transtorno do Espectro Autista), síndromes neurológicas
Palilalia	Repete as próprias palavras ("sair, sair, sair")	Neurológico e psiquiátrico
Neologismo	Palavra inventada com sentido só para o paciente ("dor espirulante")	Esquizofrenia; reflete alteração formal do pensamento
Solilóquio	Dialoga consigo em voz alta	Resposta a vozes
Pararresposta	Resposta relacionada, mas errada ("Que dia nasceu?" "Belo Horizonte")	Desorganização parcial do pensamento

Macete: ECO = do outro; PALI = de si.

10. Humor e afeto

Humor é o que o paciente sente por dentro, de forma sustentada; afeto é o que o examinador observa. No EEM descreve-se o afeto observado, não o humor referido.

Tipos de humor: normotímico (modula conforme os fatos); hipotímico (tristeza persistente, pouca energia, baixa reatividade ao prazer; depressão); hipertímico (euforia, que é alegria excessiva, ou elação, que é grandiosidade e expansividade; mania); disforia (humor desagradável, irritado e hostil, com tensão, não necessariamente tristeza); irritabilidade ("pavio curto" patológico). Disforia e irritabilidade não estão numa linha simples entre normal e triste, pois envolvem aumento de excitação, ao passo que a hipotimia envolve lentificação.

Características do afeto: sintonização (resposta compatível com o conteúdo) e irradiação (contagia o interlocutor).

Modulação do afeto, do mais ao menos expressivo:

1. **Hipermodulado:** reação teatral, desproporcional ao estímulo.
2. **Normomodulado:** reativo e proporcional.
3. **Hipomodulado:** sente, mas expressa pouco ("meu pai faleceu", dito de forma neutra); pode ocorrer no TEA.
4. **Embotado:** perda quase total da vivência e da reação emocional, rosto e voz monótonos; esquizofrenia grave e psicoses crônicas.

Outros descritores: distanciado (barreira empática), indiferente ("tá" diante de notícia grave), lábil (chora, ri e volta a chorar em minutos), incontinência afetiva (não consegue conter o choro ou o riso), congruente ou incongruente (compatível ou não com o discurso; diz estar triste e ri = incongruente) e sintônico (reativo e congruente ao contexto).

11. Pensamento

Conceito é a representação mental das coisas; juízo é a união de conceitos ("o céu é azul"); raciocínio é a relação entre juízos. O pensamento é inferido pelo discurso e avaliado em três eixos. **Mnemônico "CFC": Curso (velocidade), Forma (arquitetura), Conteúdo (tema).**

Curso:

- **Aceleração (taquipsiquismo):** mania, estimulantes, ansiedade extrema.
- **Lentificação (bradipsiquismo):** depressão grave, intoxicações, rebaixamento de consciência.
- **Bloqueio:** interrupção abrupta sem causa aparente; esquizofrenia.
- **Roubo:** sensação de que uma força externa retirou o pensamento; típico, embora raro, da esquizofrenia.

Forma:

- **Fuga de ideias:** aceleração com troca rápida de temas, mantendo ligações superficiais por assonância (amor, flor, cor, dor) ou por estímulos do ambiente. Mania, hipomania e estimulantes.
- **Escala de gravidade da desorganização (esquizofrenia):**
  1. **Afrouxamento dos laços associativos:** confuso, mas ainda se entende o tema central.
  2. **Descarrilhamento:** sai do trilho; não há conexão lógica clara entre os juízos.
  3. **Desagregação:** fragmentação total, "salada de palavras", sem tema identificável.

Macete "ADD": Afrouxa, Descarrilha, Desagrega, da mais leve à mais grave.

Conteúdo (só se descreve quando patológico): ideias delirantes, obsessivas, ideiação suicida e de morte, pensamentos depreciativos e de culpa.

Outros tipos: mágico (ignora tempo, espaço e causalidade; crer que pensamentos ou rituais mudam a realidade; infância, superstição, TOC); prolixo (muitas voltas, com tangencialidade e circunstancialidade, demorando ou não chegando ao ponto); arborizado (ramos paralelos, "por que eu estava falando isso?"); concreto (literal, não entende metáforas; deficiência intelectual, psicose, TEA, demência).

12. Juízo

- **Juízo crítico:** capacidade de avaliar as consequências dos próprios atos. Nem todo psicótico perde o juízo crítico.
- **Juízo de realidade:** diferenciar o real do imaginado e corrigir crenças diante de evidências. Quando alterado surgem ideias sobrevaloradas e delírios.

Característica	Ideia sobrevalorada	Delírio
Vínculo com a realidade	Mantém algum (houve conflito real no trabalho)	Nenhum; incompatível com a realidade compartilhada
Convicção	Forte	Certeza absoluta, irremovível
Resposta à argumentação	Pouco modificável	Imodificável por lógica ou provas
Outros traços	Egossintônica, induz ações, pode evoluir para delírio	Resulta de alteração psicopatológica; não é crença cultural

Tipos de delírio: persecutório (o mais comum; pode visar alguém específico; esquizofrenia, transtorno delirante, TAB psicótico), referência (TV e músicas falam de mim), influência (controlado por força externa; fere a consciência do eu, típico da

esquizofrenia), grandeza, místico ou religioso, erotomania (alguém famoso está apaixonado por mim), ruína (miséria, destruição), Cotard (negação de órgãos, "estou morto") e Ekbom (infestação por bichos).

Mnemônico "PRIGMERCE": Persecutório, Referência, Influência, Grandeza, Místico, Erotomania, Ruína, Cotard, Ekbom.

13. Sensopercepção

Delírio é alteração do pensamento; alucinação é alteração da percepção (percepção vivida como real, sem objeto presente).

- **Auditivas (as mais comuns nas psicoses).** Verdadeira = "escuto no ouvido, vem de fora"; o paciente descreve sexo, timbre e número das vozes, que podem comentar atos, conversar entre si ou dar ordens (imperativas). Sinais indiretos: solilóquio, mussitação, olhar atento ao vazio, latência nas respostas. Pseudoalucinação = "escuto dentro da cabeça", vivida no espaço psíquico.
- **Visuais.** Infrequentes nos transtornos psiquiátricos primários; se não forem muito congruentes com o delírio, investigue causa neurológica. Simples (vultos, luzes) ou complexas (pessoas, animais com detalhes).
- **Táteis:** choques, picadas, insetos na pele (Ekbom), toque genital.
- **Olfativas e gustativas:** em psicóticos acompanham delírio compatível; em não psicóticos pense em aura e quadros neurológicos.
- **Cenestésicas** (vísceras; associadas a Cotard), **cinestésicas** (movimento do corpo: perna encolhendo) e **sinestesia** (combinação de modalidades; descrição muito rica sugere transtorno de personalidade).
- **Não patológicas:** hipnagógicas (ao adormecer) e hipnopômpicas (ao acordar), breves e criticadas depois.

Fenômeno	Há objeto real?	Há crítica?	Associação típica
Ilusão	Sim, interpretado de forma distorcida (casaco vira pessoa)	Variável	Medo, cansaço, pouca luz, quadros orgânicos
Alucinação	Não	Não; acredita totalmente	Psicoses
Alucinose	Não	Sim; "ouço vozes, mas sei que não é real"	Orgânicos: tumores, epilepsia, alucinógenos, abstinência alcoólica, síndrome de Charles Bonnet

A alucinose auditiva é clássica no início da abstinência alcoólica, com vozes que falam do paciente em terceira pessoa; pode ocorrer também na depressão.

14. Vontade (volição)

Capacidade de avaliar, julgar e decidir, transformando intenção em ação. Integra instinto (resposta inata automática: fome, comer), desejo (o querer, que pode ou não virar ação), inclinação (tendência estável de escolha) e motivação (força propulsora interna ou externa).

- **Hipobulia:** diminuição da vontade ("sei que preciso tomar banho, mas não consigo levantar"); depressão, esquizofrenia, neurológico.
- **Abulia:** perda quase completa; fica parado o dia todo apesar de capacidade física; quadros graves e lesões frontais.
- **Ato impulsivo:** passa da intenção à execução sem ponderação, buscando satisfação imediata (automutilação em pico emocional).
- **Ato compulsivo:** repetitivo, sentido como obrigatório, irresistível apesar de reconhecido como excessivo; alivia a ansiedade (lavar as mãos, conferir a porta; TOC).

Regra de ouro: o impulso busca prazer imediato; a compulsão busca alívio da ansiedade.

15. Psicomotricidade

É a expressão motora final da volição; traduz no corpo o que ocorre no psiquismo.

- **Lentificação psicomotora:** reflete bradipsiquismo, com latência aumentada; depressão grave, demência.
- **Agitação psicomotora:** inquietação, gesticulação, frequentemente com hostilidade e risco de heteroagressividade; mania, psicose, intoxicação e abstinência.

- **Estupor:** perda de toda atividade espontânea, acordado mas sem reagir; catatonia, neurológico, metabólico.
- **Cataplexia:** perda abrupta do tônus com queda e consciência preservada, desencadeada por emoção (riso); narcolepsia.
- **Catalepsia:** hipertonia com manutenção de posturas impostas; catatonia.

Macete: cataPLEXIA = Perde o tônus e cai; cataLEPSIA = fica Largado na pose.

Catatonia é síndrome psicomotora grave, que exige reconhecimento precoce pelo risco de complicações clínicas. Pode ser imobilidade ou agitação extrema e ocorre em esquizofrenia, transtornos do humor e condições clínicas e neurológicas. Sinais: negativismo, estupor, catalepsia, agitação, ecopraxia (imita movimentos), ecolalia e obediência automática. **Mnemônico "NECO": Negativismo, Estupor e catalepsia, Ecos (ecopraxia e ecolalia), Obediência automática.**

Aula 3. Transtornos depressivos

A depressão é um transtorno de curso crônico e recidivante, com herdabilidade de 37% e fisiopatologia multifatorial (monoaminas, receptores, neurotrofinas, inflamação, microbiota e cognição). O diagnóstico é clínico, pelo DSM-5-TR, e o tratamento combina antidepressivo escolhido pelo perfil de sintomas, psicoterapia e, nos casos resistentes, potencialização ou neuromodulação.

1. Os três quadros da aula

Quadro	Tempo	Critério central
TDM (Transtorno Depressivo Maior)	2 semanas	5 ou mais sintomas, sendo 1 obrigatório (humor deprimido ou anedonia)
Transtorno Depressivo Persistente (distimia)	2 anos, sem passar mais de 2 meses seguidos sem sintomas	Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, mais 2 sintomas
Transtorno Disfórico Pré-Menstrual	Maioria dos ciclos; até 1 semana antes e até 1 semana depois da menstruação	5 sintomas, sendo pelo menos 1 afetivo

Macete dos tempos: "Maior = 2 semanas; Persistente = 2 anos".

2. Transtorno depressivo persistente (distimia)

Humor deprimido por pelo menos 2 anos, sem intervalo maior que 2 meses livre de sintomas, com ou sem motivo identificável, somado a pelo menos 2 dos seguintes.
Mnemônico "ASEADO":

- **A**petite alterado (hiporexia ou hiperfagia)
- **S**ono alterado (insônia, que é querer dormir e não conseguir iniciar ou manter o sono, ou hipersonia)
- **E**nergia baixa ou fadiga ("tudo exige grande esforço")
- **A**utoestima baixa
- **D**ificuldade de concentração ou indecisão
- **O**lhar sem esperança para o futuro (desesperança)

3. Transtorno disfórico pré-menstrual

Na maioria dos ciclos, de até 1 semana antes até 1 semana depois da menstruação, com 5 sintomas no total.

- **Afetivos (pelo menos 1 obrigatório):** labilidade do humor; irritabilidade, raiva ou mais conflitos interpessoais; humor deprimido, desesperança ou autodepreciação; ansiedade, tensão, sensação de estar "no limite".
- **Físicos e comportamentais (para completar 5):** menor interesse global; dificuldade de concentração; fadiga; apetite aumentado ou desejo por alimentos específicos; insônia ou hipersonia; sentir-se sobrecarregada ou fora de controle; sintomas físicos como mastalgia, artralgia, mialgia e inchaço.

Diferente do TDM, não exige obrigatoriamente tratamento; a paciente costuma procurar ajuda quando o incômodo é intenso ou prolongado.

4. Transtorno depressivo maior: curso e risco

Início: a incidência aumenta após a puberdade, com pico na década dos 20 anos; início em idade avançada não é incomum.

Curso: alguns remitem rápida e completamente, outros nunca remitem totalmente, e a maioria terá novo episódio na vida. O risco de recorrência cai à medida que aumenta o tempo de remissão.

Maior risco de recorrência, mnemônico "GRAVE":

- **G**ravidade ou longa duração do episódio anterior
- **R**epetição (múltiplos episódios)
- **A**ntes dos 20 anos (início precoce)

- **V**ida funcional muito prejudicada
- **E**nfrentamento mal adaptativo (coping) e alto neuroticismo (olhar sempre voltado ao negativo)

Fatores de risco que indicam rastreio:

- Clínicos: depressão prévia ou familiar; adversidade psicossocial, sobretudo desde a infância; hiperutilização do sistema de saúde; doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, neurológicas); outros transtornos psiquiátricos; períodos hormonais (periparto, perimenopausa).
- Sintomáticos: sintomas físicos inexplicados, dor crônica, fadiga, insônia, ansiedade, abuso de substâncias.

5. Critérios diagnósticos do TDM (DSM-5-TR)

5 ou mais sintomas por 2 semanas, com pelo menos 1 principal.

- **Principais:** humor deprimido; anedonia (redução acentuada de interesse ou prazer).
- **Adicionais, mnemônico "SIGECAPS" em português: "Sono, Interesse, Culpa, Energia, Concentração, Apetite, Psicomotor, Suicídio"**:
  - Sono: insônia ou hipersonia
  - Interesse: anedonia (já entre os principais)
  - Culpa excessiva ou sentimento de inutilidade
  - Energia baixa ou fadiga
  - Concentração reduzida ou indecisão
  - Apetite e peso: perda ou ganho significativo sem dieta (geralmente perda, embora obesos tenham maior tendência à depressão)
  - Psicomotor: agitação ou retardo observável por terceiros
  - Suicídio: pensamentos recorrentes de morte, ideação com ou sem plano, TAE (Tentativa de Autoextermínio)

Gravidade (altamente subjetiva):

- **Leve:** poucos sintomas além do mínimo; sofrimento manejável; pouco prejuízo. O paciente cumpre o obrigatório com mais esforço e abandona o que não é obrigatório.
- **Moderada:** entre leve e grave.
- **Grave:** muitos sintomas além do mínimo, sofrimento não manejável e prejuízo acentuado; deixa de fazer o que precisa.

6. Luto e depressão

O luto intenso pode durar curto período. Quando a interrupção importante da vida cotidiana se prolonga, independentemente do grau de parentesco, não é normal e exige investigação. Se os sintomas persistem além de cerca de 2 semanas com grande prejuízo, avalie TDM ou Transtorno do Luto Prolongado, incluído pelo DSM-5-TR (2022) no capítulo de Trauma e Estressores (ver Aula 9).

7. Fisiopatologia: as seis teorias

Mnemônico "MR. NICo": Monoaminérgica, Receptores, Neurotrófica, Inflamatória, Intestino (eixo cérebro e intestino), Cognitiva.

Base genética. Herdabilidade de 37%. O principal achado é o alelo S do gene do transportador de serotonina; polimorfismos de BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro), de genes inflamatórios e de outros receptores têm impacto menor. A epigenética explica como o ambiente "acorda" essa genética, e o trauma precoce aumenta o risco. A predisposição reduz a neuroplasticidade (capacidade de formar e desfazer sinapses, isto é, aprender, mudar de ideia e de comportamento), gerando cérebros menos plásticos. Há ainda encurtamento dos telômeros e envelhecimento celular precoce.

1. Teoria monoaminérgica. Propõe redução de serotonina, noradrenalina e dopamina, sobretudo no córtex pré-frontal. A evidência histórica veio da reserpina: esse anti-hipertensivo impede o armazenamento das monoaminas nas vesículas sinápticas, reduz sua disponibilidade e induzia depressão. Os antidepressivos aumentam as monoaminas, mas melhoram cerca de 60% dos sintomas, o que mostra que a falta de monoaminas não é a causa única.

2. Teoria dos receptores monoaminérgicos. Desloca o foco para os receptores pós-sinápticos: haveria suprarregulação compensatória de receptores, o que explica a latência de cerca de 2 semanas ou mais até a resposta. Teorias mais recentes apontam defeito na transdução de sinal distal: o neurotransmissor se liga, mas a cascata intracelular, a expressão gênica e os fatores neurotróficos funcionam mal, mesmo com monoaminas normais. Nenhuma das duas teorias tem evidência definitiva.

3. Hipótese neurotrófica. O BDNF funciona como um "regador" da árvore dendrítica, mantendo crescimento e plasticidade. Na depressão há polimorfismos do BDNF, e estudos post mortem mostram atrofia do hipocampo na depressão crônica, sugerindo perda neuronal. A plasticidade reduzida explica por que a psicoterapia rende menos em alguns pacientes: o cérebro tem dificuldade de ressignificar experiências. O principal redutor do BDNF é o estresse crônico com cortisol persistentemente elevado; contribuem também privação de sono, sedentarismo, má alimentação, adversidade na infância, inflamação crônica e genética.

4. Hipótese inflamatória. Deprimidos têm mais IL-6 e IL-1 (interleucinas 6 e 1), TNF-α (Fator de Necrose Tumoral alfa) e PCR (Proteína C Reativa). As citocinas alcançam o SNC por duas vias: a circulação, graças à maior permeabilidade da BHE (Barreira Hematoencefálica) na inflamação, e o nervo vago. No SNC reduzem monoaminas e BDNF. O sistema imune interage com o eixo HPA (Hipotálamo, Hipófise e Adrenal), elevando cortisol, citocinas e agregação plaquetária; por isso o deprimido tem pior prognóstico em doenças crônicas e maior risco cardiovascular.

Depressão com perfil inflamatório, mnemônico "LACAP": Lentidão (retardo psicomotor), Amotivação severa, Cognição prejudicada (foco e memória), Ansiedade elevada, PCR ultrassensível maior que 3. Esses sintomas sugerem depleção dopaminérgica, pedem estratégias mais dopaminérgicas e frequentemente exigem combinação de antidepressivos. Os próprios antidepressivos reduzem a biologia inflamatória.

5. Eixo cérebro e intestino. Só cerca de 1/3 da microbiota é semelhante entre as pessoas; os outros 2/3 variam com tipo de parto, amamentação, alimentação, estilo de vida e ambiente. A microbiota mantém a BHE, participa da neurogênese, amadurece a micróglia (células imunes do SNC), produz neurotrofinas e neurotransmissores e regula o eixo HPA. Na disbiose, a permeabilidade dos entérocitos aumenta, bactérias e metabólitos passam à circulação, geram citocinas que chegam ao SNC pelo vago ou pelo sangue e alteram neurotransmissores, plasticidade, neurogênese e função neuroendócrina.

6. Modelo cognitivo (Tríade de Beck). Todos têm pensamentos automáticos sobre si, o mundo e o futuro; na depressão esse conteúdo se torna negativo. A emoção não nasce da situação, mas da interpretação dela. Experiências positivas são ignoradas e as negativas são armazenadas e reforçadas. **Macete: "Eu, Mundo, Futuro", tudo negativo.**

8. Princípios do tratamento

Cerca de 50% dos episódios remitem em 1 ano mesmo sem tratamento, mas trata-se para impedir que as consequências psicológicas e biológicas se prolonguem. A decisão deve ser compartilhada, o que aumenta a adesão; o efeito placebo também contribui.

Escolha pelo perfil de sintomas, macete "Sente demais, Dorme na vida, Nada interessa":

Perfil predominante	Neurotransmissor alvo
Reatividade emocional, negativismo, muito afeto negativo ("sente demais")	Serotonina
Desmotivação, anergia, pouca iniciativa	Dopamina
Pouco interesse, má concentração, baixa energia	Noradrenalina

Dopamina e noradrenalina costumam subir juntas, porque têm vias relacionadas.

9. Antidepressivos tricíclicos (ADT)

Inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, aumentando ambas na fenda.

- **Amitriptilina:** potente ação serotoninérgica e noradrenérgica.
- **Nortriptilina:** mais noradrenérgica e com menos efeitos colaterais.
- **Imipramina:** uso off label em enurese e incontinência urinária.
- **Clomipramina:** o ADT mais serotoninérgico; muito usado no TOC.

Para depressão usam-se doses de 75 mg ou mais; doses subterapêuticas servem a outras indicações.

Cuidados, mnemônico "CIEA": Coração (arritmia, prolonga o QTc, intervalo QT corrigido), **I**nterações pelo CYP450 (citocromo P450), **E**pilepsia (reduz o limiar convulsivo), **A**nticolinérgico no idoso (quedas e confusão).

Usos off label, mnemônico "DICE": Dor crônica neuropática, **I**ntestino irritável, **C**efaleia e profilaxia de enxaqueca, **E**nurese noturna e incontinência urinária.

10. ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina)

Mecanismo completo. Bloqueiam o SERT (transportador de serotonina) e aumentam a serotonina na fenda. No início, o excesso de serotonina ativa os autorreceptores pré-sinápticos, que fazem feedback negativo e freiam a liberação. Com o uso prolongado esses autorreceptores sofrem infrarregulação (downregulation), o freio desaparece e a liberação de serotonina aumenta de forma sustentada. Esse processo explica a latência de 6 a 8 semanas para a resposta plena e a melhora gradual dos efeitos colaterais iniciais.

Fármaco	Dose	Particularidades
Fluoxetina	20 a 80 mg	No SUS; aprovada na infância e na gestação; meia-vida longa; reduz o apetite nas primeiras semanas
Sertralina	50 a 200 mg	Aprovada na infância; boa na gestação e amamentação; poucas interações; bom perfil cardiovascular
Citalopram	20 a 40 mg	Menos potente (metade da molécula se liga sem ação funcional); máximo de 30 mg acima de 85 anos pelo QTc
Escitalopram	10 a 20 mg	Fração ativa do citalopram, mais potente e puramente serotoninérgico; opção na gestação; máximo de 15 mg acima de 85 anos (QTc e hiponatremia)

Fármaco	Dose	Particularidades
Paroxetina	20 a 60 mg	O mais serotoninérgico; mais efeitos colaterais; maior ganho de peso; mais disfunção sexual
Fluvoxamina	100 a 300 mg	Muito usada no TOC

Efeitos adversos dos ISRS, mnemônico "HQ SEDI":

- **H**iponatremia por aumento do ADH (hormônio antidiurético), maior no início
- **Q**Tc prolongado, cautela no idoso
- **S**angramento por menor agregação plaquetária
- **E**mbotamento emocional ("anestesia afetiva"): o excesso de serotonina reduz a dopamina em algumas áreas
- **D**isfunção sexual: menos libido, retardo ejaculatório, anorgasmia; mais com paroxetina
- **I**nterações: fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina, com cuidado especial se associadas a ADT

11. IRSN (Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina)

Indicados quando predomina a redução do afeto positivo, com menos afeto negativo; melhoram energia, motivação, interesse e cognição.

Fármaco	Dose	Particularidades
Venlafaxina	75 a 225 mg (até 300 mg)	Muito potente; em dose baixa é só serotoninérgica; ação noradrenérgica real a partir de cerca de 150 mg; eleva pressão arterial e causa sudorese
Desvenlafaxina	50 a 200 mg	Mínima interação e metabolização hepática simples; menos disfunção sexual; trata fogachos do climatério
Duloxetina	60 a 120 mg (dor a partir de 30 mg)	Eficaz em dor neuropática e crônica mesmo sem depressão; piora doença hepática e exige cautela com álcool; menos disfunção sexual e menos retirada que a venlafaxina

Cuidados: síndrome de retirada (sobretudo venlafaxina e duloxetina) com insônia, náuseas, desequilíbrio, sensação de "choque", hiperexcitabilidade, ansiedade e quadro gripal; aumento da pressão arterial (mais na venlafaxina); alterações do sono. **Macete da**

retirada: "FINISH" em português, "Gripe, Insônia, Náusea, Desequilíbrio, Choques, Hiperexcitação".

12. Outros antidepressivos

Fármaco	Dose	Mecanismo e uso
Bupropiona	150 a 300 mg	Inibe recaptação de dopamina e noradrenalina; trata tabagismo (ação em receptores nicotínicos); quase não causa disfunção sexual e pode corrigir a causada por ISRS
Trazodona	Insônia 25 a 150 mg; depressão 150 a 375 mg (Contramid)	Liberação imediata, retardada ou Contramid (24 horas); depressão com ansiedade e insônia; pouca disfunção sexual
Vilazodona	20 a 40 mg	Depressão ansiosa; pouca disfunção sexual; náusea e diarreia, tomar com alimento
Mirtazapina	30 a 45 mg (até 60 mg)	Antagonista alfa 2 adrenérgico: bloqueia o freio pré-sináptico e aumenta noradrenalina e serotonina; sonolência (dose baixa para insônia); ganho de peso; com venlafaxina forma o "combustível de foguete da Califórnia"
Vortioxetina	10 a 20 mg (até 30 mg)	Multimodal (vários receptores serotoninérgicos e recaptação); melhor para queixas cognitivas; pouca disfunção sexual; náusea é o principal efeito
Agomelatina	25 a 50 mg	Regula o ritmo circadiano; exige monitorar função hepática

Macete "antidepressivos que poupam a vida sexual": "BUTRA VIVO DES" = Bupropiona, Trazodona, Vilazodona, Vortioxetina, Desvenlafaxina (e duloxetina menos que venlafaxina).

13. Tratamento adjuvante e depressão resistente

Lítio. Tem efeito antissuicídio transdiagnóstico. Pode funcionar como monoterapia, mas não é primeira, segunda nem terceira linha na depressão aguda. Como potencializador, pode reduzir a latência de resposta. Fora do TAB não é obrigatório atingir litemia terapêutica, embora seja recomendado monitorar.

Antipsicóticos potencializadores: aripiprazol, brexpiprazol, quetiapina, olanzapina e risperidona. São das estratégias mais estudadas na depressão resistente, limitadas pela tolerabilidade: ganho de peso e alterações metabólicas, hiperprolactinemia, sintomas extrapiramidais e prolongamento do QTc.

ECT (Eletroconvulsoterapia). Mecanismo ainda não totalmente esclarecido (a aula cita a teoria CCTCG); métodos não convulsivos são menos eficazes. Indicações que somam 80% a 90% dos casos: depressão refratária, baixa tolerância a medicamentos e risco iminente de suicídio. Reduz a ideação suicida em 38% após 1 semana, 61% após 2 semanas e 81% ao final. Efeitos: imediatos (cefaleia, náuseas e vômitos pelo anestésico, confusão pós ictal), de curto prazo (amnésia anterógrada lacunar benigna e autolimitada, delirium) e de longo prazo (amnésia anterógrada e relatos de retrógrada), embora a memória desses pacientes acabe semelhante à da população geral. **Não tem contraindicações absolutas.**

Escetamina. Para depressão resistente e alto risco de suicídio, sempre associada a um antidepressivo, em dose subanestésica, por via endovenosa, subcutânea ou intranasal (Spravato), em ambiente controlado e em múltiplas sessões. Mecanismo em cascata: antagoniza o receptor NMDA (N-metil-D-aspartato), o que aumenta glutamato e dopamina no córtex pré-frontal; o glutamato ativa receptores AMPA (ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico), que elevam o BDNF e restauram a neuroplasticidade.

EMT (Estimulação Magnética Transcraniana). Não invasiva, cara, paciente acordado e sem convulsão; menos eficaz que a ECT, exige mais sessões e tem muito poucos efeitos colaterais.

14. Psicoterapias

TCC (Terapia Cognitivo Comportamental). Reestruturação cognitiva: identificar pensamentos automáticos negativos e distorções (catastrofização, generalização, pensamento dicotômico "tudo ou nada"), questioná-los pelo método socrático ("Quais evidências sustentam isso?", "Existe explicação alternativa?", "O que de pior aconteceria e como você lidaria?", "Isso é fato ou sentimento?") e substituí-los por interpretações realistas.

Ativação comportamental. A perda de reforço positivo contribui para a depressão; o objetivo é reintroduzir fontes de reforço e uma vida com valor e propósito. Princípio central: **agir primeiro para a motivação vir depois**. Mapeia-se o repertório

comportamental, identificando atividades prazerosas (maior engajamento) e aversivas (maior esquiva).

Terapia interpessoal. Tempo limitado, para fase aguda da depressão maior unipolar não psicótica, focada nas relações. Quatro áreas problema, **mnemônico "LDMD" ("Luto Divide Mudanças Difíceis")**: Luto (aceitar a perda e reintegrar), Disputas interpessoais (expectativas divergentes e negociação), Mudança de papel (emprego, casa, divórcio, aceitação da nova realidade) e Déficits interpessoais (isolamento, ampliar rede e habilidades de comunicação).

Aula 4. Transtorno bipolar

O TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) é crônico, episódico e neuroprogressivo, exige a identificação obrigatória de mania ou hipomania e se trata com estabilizadores do humor, sobretudo lítio e quetiapina, evitando ao máximo os antidepressivos. Entre os pacientes diagnosticados com depressão, 12,5% a 30% são na verdade bipolares; o risco de suicídio é 15 vezes maior que na população geral; o diagnóstico do tipo II pode demorar até 20 anos; e a herdabilidade é alta.

1. Os três episódios

Episódio	Duração mínima	Gravidade
Maníaco	7 dias, ou qualquer duração se houver internação	Prejuízo acentuado, internação ou sintomas psicóticos
Hipomaníaco	4 dias consecutivos	Mudança clara e perceptível do funcionamento, sem prejuízo grave, sem internação e sem psicose
Depressivo maior	2 semanas	Mesmos critérios do TDM

Macete "7, 4, 14": mania 7 dias, hipomania 4 dias, depressão 14 dias. Se houver psicose ou internação, é mania por definição.

2. Sintomas maniformes

Humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável com aumento de energia ou atividade, **mais 3 sintomas (ou 4, se o humor for apenas irritável)**. **Mnemônico "DIGA FAST" adaptado, "GRANDE FALA":**

- **G**randiosidade ou autoestima inflada
- **R**edução da necessidade de sono (descansado após poucas horas)

- **A**celeração do pensamento ou fuga de ideias
- **N**ecessidade de falar: loquacidade e pressão para falar
- **D**istraibilidade por estímulos irrelevantes
- **E**nvolvimento em atividades danosas (gastos, sexo de risco, decisões impulsivas)
- **FALA** lembra o aumento de atividade dirigida a objetivos (profissional, social, sexual) ou agitação psicomotora

3. Tipos e espectro

- **TAB tipo I:** pelo menos 1 episódio maníaco na vida; depressão pode ocorrer, mas não é necessária.
- **TAB tipo II:** pelo menos 1 hipomania e 1 depressão maior, sem nenhuma mania (uma mania reclassifica como tipo I).
- **Ciclotimia:** diagnóstico próprio, não especificador. Oscilações crônicas com sintomas hipomaníacos e depressivos que não fecham critérios completos, por pelo menos 2 anos, sem passar mais de 2 meses seguidos assintomático, não explicadas por substâncias, TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual) ou condição médica. É "a distimia da bipolaridade": o prejuízo vem da imprevisibilidade dos altos e baixos. Até 50% evoluem para TAB, e a rotina estruturada (sono, atividades, tratamento) ajuda muito.

Macete: "Tipo 1 = 1 mania basta; Tipo 2 = 2 polos, hipomania e depressão".

4. Conceitos que caem em prova

- **Transtorno do humor difícil de descrever:** pergunte por energia, atividade e produtividade, mais úteis que perguntar pelo humor. Na hipomania o paciente assume múltiplas tarefas e frequentemente termina em sobrecarga e burnout.
- **Crônico:** dura a vida toda, e o tratamento farmacológico e não farmacológico também.
- **Episódico:** episódios intercalados por estabilidade.
- **Eutimia:** período estável, sem sintomas significativos; o humor ainda oscila levemente com os eventos, o que é fisiológico. No TAB essas oscilações se tornam extremas.
- **Episódio misto:** sintomas simultâneos dos dois polos, geralmente como depressão com características mistas. Reúne "a pior parte dos dois polos": energia baixa e incapacidade de agir com mente acelerada e agitação interna. É mais grave e mais difícil de manejar.
- **Ciclagem rápida:** especificador do tipo I ou II. Quatro ou mais episódios (maníacos, hipomaníacos ou depressivos) em 12 meses; se forem só de um polo, conta-se 2 episódios a cada 2 meses ao longo do ano. Cada episódio é delimitado por remissão de pelo menos 2 meses ou por virada direta para o polo oposto. Dificulta a estabilização.

5. Neurobiologia e neuroprogressão

Achados biológicos, mnemônico "CIBLe Na/K": Citocinas inflamatórias elevadas nos episódios; **I**nibição do ciclo de Krebs com menos energia mitocondrial; **B**DNF reduzido (menos neuroplasticidade e proteção); **L**impeza deficiente de escórias metabólicas intracelulares (falha da autofagia); bomba **Na^+/K^+ ATPase** alterada, que desestabiliza o potencial de membrana e a excitabilidade neuronal.

Bipolaridade do sistema dopaminérgico. Na mania e na hipomania a dopamina aumenta nas vias mesolímbicas, gerando euforia, impulsividade e energia. O cérebro compensa aumentando o DAT (Transportador de Dopamina) e a recaptação. Na eutimia e na depressão o DAT continua elevado, a recaptação excessiva derruba a dopamina sináptica e o paciente afunda no polo depressivo. É um pêndulo: a própria compensação da mania prepara a depressão.

Por que é neuroprogressivo. Cada episódio maníaco ou hipomaníaco ativa cascatas de dopamina e glutamato que disparam apoptose e degeneração neuronal, somadas à inflamação, à queda do BDNF e à falha mitocondrial. Sem tratamento, a doença começa leve (com sinais já na infância) e os episódios ficam mais graves e frequentes, podendo evoluir para déficit cognitivo semelhante à demência. Prevenir episódios é, portanto, neuroproteção.

6. Diagnóstico diferencial

Critério	TAB	Borderline	TDAH
Duração das alterações	Dias a semanas	Horas	Labilidade breve
Curso	Episódico, com eutimia	Crônico, reativo	Crônico e contínuo desde a infância
Gatilho	Pode não haver	Conflito interpessoal, medo de abandono	Estímulos externos
Identidade e relações	Não são centrais	Autoimagem instável, idealização e desvalorização	Não são centrais
Impulsividade e suicídio	Impulsivo na mania; suicídio ligado à depressão	Impulsividade crônica, automutilação, ideação recorrente	Inquietação constante
Energia	Muito alta na mania, baixa na depressão	Variável conforme o contexto	Hiperatividade relativamente constante

Critério	TAB	Borderline	TDAH
Sono	Menor necessidade de sono na mania	Não é critério	Demora a iniciar, mas precisa dormir normalmente

Pergunta de ouro para separar TAB de TDAH: "Você dorme pouco e acorda cansado, ou dorme pouco e acorda cheio de energia?". Só o bipolar em mania dorme pouco e não sente falta do sono.

7. Suicídio no TAB

Risco até 15 vezes maior. A frequência de tentativas é semelhante nos tipos I e II, mas **a letalidade é maior no tipo II**. Fatores de risco, **mnemônico "CMTF" ("Cuidado, Muito Tempo Fica")**: Ciclagem rápida, episódio Misto, Tentativa prévia, história Familiar de suicídio.

8. Lítio

Estabilizador do humor, neuroprotetor (reduz a neuroprogressão) e antissuicídio transdiagnóstico. Dose individualizada pela clínica e pelo nível sérico. **No TAB é obrigatório buscar litemia terapêutica; na mania, cerca de 1,0 mEq/L (miliequivalente por litro).** Em outros transtornos, ajusta-se pela resposta clínica.

Protocolo de litemia, macete "1 semana, 12 horas, S M T":

1. Primeira dosagem após 1 semana de uso regular.
2. Coleta 12 horas após a última tomada (nível de vale).
3. Frequência: semanal até estabilizar, mensal por mais 2 a 3 meses, trimestral pelo resto do primeiro ano ou enquanto usar; se muito estável e sem fatores de risco, semestral.

Exames trimestrais: litemia, TSH (hormônio tireoestimulante), creatinina e cálcio. Macete "L TCC": Lítio, Tireoide, Creatinina, Cálcio.

Interações que elevam a litemia, com o mecanismo. O lítio é eliminado pelo rim e reabsorvido junto com o sódio no túbulo proximal, porque o rim não distingue bem os dois íons. Diuréticos causam perda de sódio e o túbulo compensa reabsorvendo mais sódio e, junto, mais lítio. Os AINE (Anti-inflamatórios Não Esteroidais) reduzem as prostaglandinas que mantêm o fluxo sanguíneo renal, e a filtração do lítio cai. Há relatos também com IECA (Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina), metronidazol e propranolol. **Macete "DIA": Diuréticos, IECA, AINE.**

Diabetes insípido. Aumento importante do volume urinário deve levar à investigação de diabetes insípido com urina de 24 horas; o lítio reduz a resposta do ducto coletor ao ADH (hormônio antidiurético) e o rim deixa de concentrar a urina. Atente para intoxicação por

lítio nesse contexto.

Gestação: uso controverso; risco baixo de malformação cardíaca; se a gestante usar, litemia mensal.

9. Anticonvulsivantes estabilizadores

Fármaco	Indicação	Dose e titulação	Cuidados
Lamotrigina	Aprovada só para depressão bipolar	Alvo 200 a 400 mg (pode responder com menos); inicia 25 mg e sobe a cada 2 semanas, podendo dobrar a dose, de preferência passando por doses intermediárias	Risco de virada maníaca, associar a outro estabilizador; rash cutâneo
Ácido valproico, valproato ou divalproato	Mania aguda e manutenção (bom em ciclagem rápida, ansiedade e estados mistos); segunda linha na depressão	750 a 1800 mg (até 3 g); inicia 250 mg e sobe a cada 2 dias; guia-se pela resposta clínica, sem dosagem obrigatória	Efeitos gástricos; rash obriga suspender; teratogênico, proscrito em mulheres em idade fértil sem controle rigoroso
Carbamazepina	Mania aguda e manutenção em segunda linha; não serve para depressão	Pouco usada hoje	Muitas interações, menor evidência

Macete da lamotrigina: "LAMOtrigina, LA embaixo", trata o polo de baixo (depressão) e sobe devagar, porque a titulação lenta reduz o risco de rash grave.

Associação proibida: lamotrigina com ácido valproico. O valproato inibe a metabolização da lamotrigina, eleva seus níveis e aumenta muito o risco de rash grave, incluindo síndrome de Stevens Johnson.

10. Antidepressivos e antipsicóticos no TAB

Risco dos antidepressivos: instabilidade ao longo do tempo, mais estados mistos e mais ciclagem rápida. Evite ao máximo.

Depressão bipolar:

- Primeira escolha: lítio, quetiapina, lamotrigina e lurasidona (esta, na manutenção, apenas associada a algo que previna a virada).
- Olanzapina mais fluoxetina: terceira linha, com muito cuidado, para paciente muito deprimido.
- Se usar antidepressivo no episódio depressivo, **retire na manutenção**.

11. Síntese do tratamento

- O objetivo é tratar e prevenir episódios, conforme o polo e a predominância de polo.
- **Lítio e quetiapina são padrão ouro, aprovados para todas as fases**; quando a monoterapia funciona, costuma ser com um deles.
- A monoterapia é rara; o usual é combinar.
- **Lítio com lurasidona** é útil em pacientes com predomínio de episódios depressivos.
- Nunca associe lamotrigina com valproato.

Mnemônico final "LQ ouro, LaLu embaixo, Valpro em cima": Lítio e Quetiapina para tudo; Lamotrigina e Lurasidona para a depressão; Valproato para a mania.

Aula 5. Comportamento suicida

Suicídio é o ato deliberado, consciente e intencional, executado pelo próprio indivíduo, cuja finalidade é a morte, usando um meio que ele acredita ser letal. Em cerca de 90% dos casos há transtorno mental associado, o que multiplica o risco por cerca de 8. Perguntar ativamente sobre suicídio não induz o comportamento e é obrigatório.

1. Escada de gravidade crescente

Cada degrau indica maior estruturação e maior letalidade. **Mnemônico "I I D I P T S", lido como "Ideias Idas Deixam Intensos Planos, Tentativas, Suicídio"**:

1. **Ideação de morte (passiva):** querer sumir, achar que morrer seria boa solução, sem intenção de agir.
2. **Ideação suicida (ativa):** pensamentos dirigidos a atentar contra a vida, ainda sem desejo plenamente consciente de morrer.
3. **Desejo de suicídio:** vontade consciente e estruturada de morrer.
4. **Intenção de suicídio:** busca de informações e consideração prática de meios.
5. **Planejamento:** método, momento, local e forma definidos; é o estágio de maior gravidade antes do ato.
6. **Tentativa:** comportamento autoagressivo com intenção de morte.

7. **Suicídio consumado.**

2. Psicopatologia: os três estados mentais do suicídio

Mnemônico "AIR" (o paciente precisa de ar):

- **Ambivalência:** coexistem o desejo de viver e a urgência de cessar o sofrimento. É a janela terapêutica: a presença de esperança reduz muito o risco.
- **Impulsividade:** respostas rápidas a gatilhos emocionais, levando a tentativas sem planejamento em sofrimento momentâneo.
- **Rigidez de pensamento:** visão cristalizada em que o suicídio parece a única solução; indica alto risco.

3. Fatores de risco

Não modificáveis	Modificáveis
Jovens de 15 a 30 anos e idosos	Desemprego, problemas financeiros, trabalho não qualificado (maior risco nos 3 primeiros meses da mudança)
Perdas recentes	Incerteza quanto à orientação sexual
Gênero: homens consumam mais, mulheres tentam mais	Aposentadoria
Cônjuge de alguém que se suicidou	Alto neuroticismo e baixa resiliência
Em adolescentes, suicídio de figura proeminente ou de conhecido	Situação de rua
Adversidades na infância: maus tratos, abuso físico e sexual, divórcio dos pais, transtorno psiquiátrico familiar	Fácil acesso a meios letais
Populações especiais: imigrantes, indígenas, alguns grupos étnicos	Viver sozinho (divorciado, viúvo, solteiro, sem filhos)
História familiar de suicídio ou tentativa	Conflitos familiares
Doenças clínicas crônicas debilitantes	Falta de apoio social

Macete do gênero: "Homem Consuma, Mulher Tenta" (HC MT).

4. Abordagem do paciente

Mnemônico "PAVIS" (o paciente precisa de um aviso de cuidado):

- **P**erguntar ativamente sobre morte e suicídio, sem evitar o tema.
- **A**valiar em detalhe pensamento, intenção, plano e meios disponíveis.
- **V**ínculo terapêutico, elemento central para adesão e redução de risco.
- **I**nvestigar fatores protetores: filhos, religião, vínculos afetivos, projetos de vida.
- **S**uporte sociofamiliar: rede de apoio e condições de cuidado fora do hospital, que orientam a decisão de internar.

5. Avaliação do risco

Sinais de risco elevado, **mnemônico "PERDE TUDO"**:

- **P**ersistência da intenção suicida
- **E**stado misto e outros diagnósticos psiquiátricos
- **R**ecusa ao tratamento
- **D**esesperança, forte preditor
- **E**xpectativa frustrada por tentativa não consumada, que aumenta a determinação
- **T**entativas prévias, um dos principais fatores
- **U**m familiar que se suicidou (história familiar)
- **D**esamparo: falta de suporte e de condições para tratamento extra-hospitalar
- **O**bjeto letal acessível, como arma de fogo

Ao investigar tentativas prévias, avalie: número; se foi planejada (mais letal) ou impulsiva; gatilhos agudos das impulsivas; método, letalidade e nível de intenção; necessidade de hospitalização clínica ou psiquiátrica.

6. Diagnósticos associados

- **Transtornos do humor.** O TDM (Transtorno Depressivo Maior) é o mais associado em números absolutos, porque é muito mais prevalente e expõe mais pessoas. O TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) tem o maior risco proporcional: cada bipolar, individualmente, tem mais chance do que um deprimido unipolar.
- **Ansiedade:** sofrimento psíquico intenso.
- **Uso de substâncias:** impulsividade e desinibição.
- **Esquizofrenia:** sobretudo nas fases iniciais ou com sintomas ativos.
- **Transtornos de personalidade:** principalmente os com impulsividade e instabilidade emocional.

Diferença que cai em prova: "absoluto" = depressão; "proporcional" = bipolar.

7. Conduta após uma TAE (Tentativa de Autoextermínio)

1. Acolhimento imediato, empático e sem julgamento.
2. Manejo clínico inicial com estabilização física e psíquica.
3. **Notificação compulsória imediata no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).**

8. Prevenção

Populacional: restringir o acesso a meios letais como pesticidas e armas de fogo (o envenenamento por pesticidas responde por cerca de 20% dos suicídios); reduzir o tamanho das embalagens de medicamentos e tóxicos, o que frustra tentativas impulsivas; parceria com redes sociais para identificar e remover conteúdo nocivo; desenvolver habilidades socioemocionais em adolescentes; identificar precocemente indivíduos em risco, com acompanhamento contínuo.

Mídia responsável (contra o efeito contágio): não detalhar métodos; evitar sensacionalismo e exposição excessiva; valorizar histórias de recuperação e tratamento; promover narrativas de esperança.

Farmacológica:

- **Escetamina e ECT (Eletroconvulsoterapia):** ação direta e rápida na redução da ideação suicida em casos graves e resistentes.
- **Lítio:** redução comprovada do risco de suicídio, com início de ação relativamente mais rápido que outros estabilizadores. Exige litemia periódica pela janela terapêutica estreita e vigilância de intoxicação. O mecanismo não está totalmente elucidado, embora a eficácia seja conhecida há mais de 40 anos. É pouco usado na prática por menor divulgação, necessidade de monitoramento, efeitos adversos e complexidade de manejo.

Campanha Setembro Amarelo: criada pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), em referência ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro.

Aula 6. Transtornos psicóticos

Psicose é a síndrome que compromete a capacidade mental, a resposta afetiva, o reconhecimento da realidade, a comunicação e a relação interpessoal; define os transtornos psicóticos, mas também aparece nos transtornos do humor. O grupo inclui esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, transtorno psicótico

breve e transtorno esquizoafetivo. O tratamento se baseia no antagonismo D2 (receptor de dopamina tipo 2), modulado nos atípicos pelo antagonismo 5-HT2A (receptor de serotonina tipo 2A).

1. Os cinco domínios da psicose

Mnemônico "DAP-CN" ("Delira, Alucina, Pensa torto, Comporta torto, Nega"): Delírio, Alucinação, Pensamento desorganizado, Comportamento desorganizado ou catatônico, sintomas Negativos.

Delírio. Alteração do juízo de realidade e do **conteúdo** (não da forma) do pensamento: crença fixa, irremovível, imune à lógica e às evidências. Pode ser **bizarro** (claramente implausível no contexto cultural) ou **não bizarro** (possível, embora improvável, como ser perseguido por alguém). Além dos tipos vistos na Aula 1, esta aula acrescenta: hipocondríaco (doença grave sem evidência), de reivindicação ou querelância (vítima de injustiça, busca constante de reparação), de invenção ou descoberta, e Ekbom, que pode gerar escoriações pela tentativa de remover os "parasitas" sem necessariamente haver alucinação.

Alucinação. Percepção sem objeto externo correspondente.

Pensamento desorganizado. Alteração da **forma**, em gravidade crescente: afrouxamento, descarrilhamento e desagregação ("salada de palavras").

Comportamento desorganizado. Alteração psicomotora com atitudes tolas e pueris, maneirismos, agitação imprevisível e, nos graus mais graves, rigidez ou estupor.

Catatonia. Síndrome psicomotora grave com redução acentuada da reatividade. Vai do negativismo a posturas rígidas e bizarras, mutismo e estupor, mas também pode ser excitação catatônica (atividade motora excessiva sem propósito). Manifestações: ecolalia, automatismos, movimentos erráticos, posturas desconfortáveis mantidas por longo tempo. **Na depressão, a catatonia tem mais negativismo e não tem flexibilidade cérea, que pode ocorrer na esquizofrenia.**

2. Sintomas negativos

Redução global de volição, afeto, pensamento e cognição, possivelmente por hiperativação de algumas áreas e hipoativação compensatória de outras. Existem também na depressão, com apresentação diferente. **Mnemônico dos "5 A + 2": Afeto diminuído, Avolição e apatia, Associabilidade, Alogia, Anedonia, mais pensamento concreto e prejuízo cognitivo.**

- **Expressão emocional diminuída:** menos mímica facial, contato visual, entonação e gestos.

- **Avolição e apatia:** menos atividades autoiniciadas; apatia é falta de iniciativa, avolição é falta de vontade e energia para agir.
- **Associabilidade:** pouco interesse social, ligado à avolição e à perda de oportunidades e de autonomia.
- **Alogia:** fala pobre em produção, fluência e conteúdo, com frases simples.
- **Anedonia:** menor capacidade de sentir prazer e de recordar experiências prazerosas.
- **Pensamento concreto:** literalidade (ditados interpretados ao pé da letra).
- **Prejuízo cognitivo:** atenção, funções executivas e inteligência, grande fonte de prejuízo funcional.

3. Esquizofrenia: critérios diagnósticos

A. Sintomatologia: 2 ou mais dos 5 domínios por pelo menos 1 mês (ou menos, se tratado com sucesso), sendo **obrigatório pelo menos 1 nuclear: delírio, alucinação ou pensamento desorganizado**.

B. Comprometimento funcional: queda acentuada em trabalho, relações ou autocuidado, comparada ao próprio nível prévio. A esquizofrenia rompe a trajetória de vida: o paciente não volta ao nível anterior mesmo quando os sintomas produtivos melhoram, porque o prejuízo se liga aos sintomas negativos, centrais e persistentes.

C. Duração: sinais contínuos por pelo menos 6 meses, incluindo fases ativas e residuais (geralmente negativas).

4. A régua do tempo nas psicoses

Diagnóstico	Duração	Observação
Transtorno psicótico breve	Menos de 1 mês (até 30 dias)	Remissão completa
Transtorno esquizofreniforme	De 1 mês a menos de 6 meses	Quadro de esquizofrenia ainda sem o tempo mínimo
Esquizofrenia	6 meses ou mais	Inclui fases residuais
Transtorno delirante	Delírio por 1 mês ou mais	Nunca preencheu o critério A da esquizofrenia
Esquizoafetivo	Longitudinal	Psicose isolada por 2 semanas ou mais sem humor alterado

Macete "1, 6": menos de 1 mês = Breve; entre 1 e 6 = Forme; 6 ou mais = Esquizofrenia.

5. Morbimortalidade

O esquizofrênico vive menos.

- **Doença cardiovascular prematura** é a principal causa de morte, como na população geral, porém mais cedo. Contribuem tabagismo (alta prevalência), sedentarismo (apatia e sintomas negativos), dieta inadequada (dependência familiar), sobrecarga familiar e antipsicóticos de segunda geração, ligados à síndrome metabólica. **Macete "TSDSA": Tabaco, Sedentarismo, Dieta, Sobrecarga, Antipsicótico.**
- **Suicídio:** 25% a 50% fazem TAE (Tentativa de Autoextermínio) na vida e cerca de 10% consumam.
- **Negligência médica:** pior desfecho mesmo em outras doenças.

6. Personalidade pré-mórbida e prognóstico

Descrição retrospectiva, não diagnóstica, do funcionamento anterior à doença.

Perfil	Traços	Implicação
Esquizoide	Pobreza afetiva, pouca necessidade de vínculos, indiferença social	Pior prognóstico, predomínio de negativos
Esquizotípica	Excentricidade, pensamento mágico, linguagem estranha	Maior risco de evoluir para esquizofrenia
Sensitiva	Hipersensibilidade à crítica, timidez, ressentimento, desconfiança, ruminação	Formas paranoides, delírio persecutório
Bem adaptado	Sem traços marcantes	Melhor prognóstico

Fatores prognósticos, mnemônico "DIP 5":

- **D**UP (Duration of Untreated Psychosis, duração da psicose não tratada): quanto maior, pior, pelo efeito neurotóxico da psicose prolongada. É um dos principais fatores.
- **I**dade do primeiro surto: quanto mais precoce, pior; o início tardio é melhor porque o cérebro teve mais tempo para amadurecer sinapses e conexões.
- **P**ersonalidade pré-mórbida: isolamento e negativos prévios pioram; boa adaptação melhora.
- **5** primeiros anos: período decisivo, com tratamento farmacológico adequado e intervenções não farmacológicas (reabilitação psicossocial, socialização, abordagem comportamental, participação familiar).

7. Transtorno delirante

Delírio, bizarro ou não, por pelo menos 1 mês; o critério A da esquizofrenia nunca foi atendido; alucinações, se houver, são discretas e congruentes com o delírio. Prevalência de cerca de 0,2%, sendo o persecutório o mais comum. O diagnóstico é relativamente estável, mas parte evolui para esquizofrenia.

A chave é a funcionalidade: o prejuízo é circunscrito ao tema do delírio e o comportamento não é bizarro. Exemplo: a paciente que acredita ser perseguida pela vizinha evita o mercado quando acha que ela estará lá, mas cozinha, cuida da casa e da higiene normalmente. Na esquizofrenia, ao contrário, a queda é global e persistente.

8. Transtorno esquizoafetivo

Episódio de humor (depressivo maior ou maníaco) simultâneo a sintomas do critério A da esquizofrenia, em período ininterrupto de doença.

Critério fundamental: pelo menos 2 semanas de sintomas exclusivamente psicóticos (delírios ou alucinações), sem alteração do humor, seja porque o humor remitiu e a psicose persistiu, seja porque ocorreram em momentos distintos. É isso que o separa do transtorno do humor com sintomas psicóticos, no qual a psicose só existe dentro do episódio de humor. Também não é esquizofrenia, pela presença marcante e recorrente de episódios de humor. O diagnóstico é longitudinal.

Subtipos: bipolar (há mania, com ou sem depressão) e depressivo (só depressão).

Macete: "No esquizoafetivo a psicose anda sozinha por 2 semanas; no humor psicótico ela nunca sai sem o humor".

9. Hipótese dopaminérgica e as quatro vias

Explica sobretudo os sintomas positivos: anfetaminas e cocaína, que aumentam a dopamina, induzem ou pioram delírios e alucinações, e fármacos que reduzem a dopamina os melhoram. Vale para os transtornos psicóticos em geral.

Via	Função	Na psicose	Efeito do bloqueio D2
Mesolímbica	Motivação, emoção, recompensa	Hiperfunção = sintomas positivos	Reduz os positivos (efeito desejado)
Mesocortical	Cognição, função executiva, afeto	Hipofunção = sintomas negativos	Em dose alta piora os negativos; em dose baixa interfere pouco

Via	Função	Na psicose	Efeito do bloqueio D2
Nigroestriatal	Movimento voluntário; contém cerca de 80% da dopamina cerebral	Normal	Sintomas extrapiramidais: discinesia, distonia (por exemplo disfonia)
Tuberoinfundibular	Dopamina inibe a prolactina	Normal	Hiperprolactinemia e galactorreia

Mnemônico "MeMeNiTu" = "Mais, Menos, Neuro-motor, Tetas": Mesolímbica com dopamina a Mais (positivos), Mesocortical com dopamina a Menos (negativos), Nigroestriatal motor (extrapiramidal), Tuberoinfundibular com prolactina (galactorreia).

Por que os atípicos são diferentes. Todos os antipsicóticos bloqueiam D2. Os atípicos têm afinidade diferente pelos receptores, o que deixa as áreas prejudicadas com mais ação da dopamina endógena. Além disso bloqueiam o 5-HT2A: a serotonina, ao ativar esse receptor, reduz a dopamina no córtex pré-frontal; bloqueando o 5-HT2A, o freio cai e a dopamina sobe em algumas áreas. Resultado: menor piora dos negativos, menos extrapiramidais e menos hiperprolactinemia. Esse efeito é menos relevante que o antagonismo D2, mas define o perfil clínico dos atípicos.

10. Antipsicóticos típicos (primeira geração)

Classificados pela afinidade D2.

- **Baixa potência:** clorpromazina (Amplictil) e levomepromazina (Neozine). Mais sedação, hipotensão e efeito anticolinérgico. **Macete "baixa potência, alto SHA": Sedação, Hipotensão, Anticolinérgico.**
- **Alta potência:** alta afinidade D2 e maior risco extrapiramidal. Haloperidol (Haldol), disponível no SUS, por via oral, intramuscular de ação imediata (agitação aguda) e intramuscular de depósito (decanoato) a cada 2 a 4 semanas; trifluoperazina (Stelazine); zuclopentixol (Clopixol).
- **Outro:** periciazina (Neuleptil), com possível benefício cognitivo.

11. Antipsicóticos atípicos (segunda geração)

Fármaco	Dose	Pontos de prova
Risperidona	1 a 8 mg	"O mais típico dos atípicos"; paliperidona é seu metabólito ativo

Fármaco	Dose	Pontos de prova
Olanzapina	5 a 20 mg (até 30 mg)	Poucos extrapiramidais; seda (as "pinas" ajudam o sono); ganho de peso importante
Ziprasidona	80 a 160 mg	Pode ser menos eficaz; tomar com refeição de cerca de 500 kcal para absorver; bom perfil metabólico
Quetiapina	400 a 800 mg na esquizofrenia	Menos potente; TAB em todas as fases; escolha em gestante bipolar; potencializa depressão unipolar; delirium; sintomas neuropsiquiátricos da demência; pode falhar na mania grave
Clozapina	Esquizofrenia refratária	Múltiplos mecanismos, baixa afinidade D2
Aripiprazol	Esquizofrenia, TAB, potencialização da depressão	Agonista parcial D2; excelente perfil metabólico; acatisia
Brexpiprazol	Adjuvante na depressão; esquizofrenia em doses altas; demência	Agonista parcial D2 com importante ação serotoninérgica

Farmacodinâmica da quetiapina, o conceito "dose define o receptor". Ela tem baixa afinidade por D2, então precisa de concentrações altas para ocupá-lo. No caminho, em concentrações menores, ocupa primeiro outros receptores: H1 (histamina, sedação, daí o uso em dose baixa para o sono), receptores serotoninérgicos e, levemente, o transportador de noradrenalina, o que lhe confere efeito antidepressivo. Só em dose alta vira antipsicótico.

Agonismo parcial do aripiprazol. A dopamina ativa o D2 por completo; o antagonista bloqueia por completo; o aripiprazol se liga e produz cerca de 1/3 da ação da dopamina. Onde há excesso (mesolímbica), ao ocupar o receptor ele "rebaixa" a ativação para 1/3, e o resultado é redução global sem supressão total. Por isso é chamado de modulador dopaminérgico. Precisa de dose alta para competir com a dopamina endógena. O efeito adverso marcante é a **acatisia**: inquietação e incapacidade de ficar parado; o esquizofrênico pode não verbalizar (o examinador percebe), enquanto o bipolar relata inquietação intensa.

Clozapina na prática. Indicada após falha de 2 antipsicóticos em dose moderada a alta e por tempo adequado (semanas). Efeito comum: constipação. Efeito raro e grave: neutropenia ou agranulocitose, que exige hemograma. **Macete "18 e 18": semanal nas 18**

primeiras semanas, quinzenal nas 18 seguintes, depois mensal enquanto usar.

Refratários ou intolerantes à clozapina (que costuma ser a última opção): ECT (Eletroconvulsoterapia) de manutenção, também indicada se houver sedação excessiva, efeitos anticolinérgicos relevantes ou neutropenia.

12. Efeitos adversos graves

Discinesia tardia. Movimento hipercinético após mais de 1 ano de antipsicótico (geralmente muito mais), que pode ser irreversível. Tratamento: trocar para clozapina, dando "descanso ao D2", pois ela atua sobretudo em outros receptores.

Síndrome neuroléptica maligna. Em geral após uso agudo de grande quantidade de antipsicótico. **Mnemônico "FARRL" ("FEBRE ARRiscada")**: Febre (hipertermia), Alteração flutuante da consciência, Rigidez (hipertonia), Rabdomiólise com leucocitose, Labilidade autonômica (pressão arterial, pulso e frequência respiratória). Conduta: **suporte intensivo**.

Aula 7. Transtornos de ansiedade

Todos os transtornos de ansiedade têm a preocupação como base; o que os distingue é o foco de apreensão. São muito comórbidos entre si, podem migrar de um para outro ao longo da vida, regredir a níveis subsindrômicos e reaparecer como outro transtorno ansioso ou como TDM (Transtorno Depressivo Maior). A depressão que surge nesse contexto tem hiporexia, fadiga, apatia e mais tempo em repouso, como se o sistema emocional se esgotasse. A base do tratamento é TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) com exposição e antidepressivos ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina) como primeira linha.

1. Conceitos de base

- **Medo:** resposta a ameaça real, imediata e identificável.
- **Ansiedade:** antecipação de ameaça futura, vaga, com preocupação persistente.
- **Agitação:** inquietação psicomotora (não consegue ficar parado, torce as mãos, mexe-se na cadeira), com pensamento acelerado, pressão para falar e impulsividade, como na mania. A ansiedade é preocupação; a agitação é motora e comportamental.

Macete: medo é "agora e aqui"; ansiedade é "e se amanhã...".

2. Mapa dos transtornos e seus focos

Transtorno	Foco de apreensão	Tempo mínimo
Ansiedade de separação	Afastar-se da figura de apego; choro e sintomas somáticos (mais comum na infância)	Não detalhado na aula
Mutismo seletivo	Fala preservada, mas inibida em certos ambientes sociais (crianças e adolescentes)	Não detalhado na aula
Fobia específica	Objeto ou situação específica	6 meses
Ansiedade social	Avaliação negativa pelos outros	Não detalhado na aula
Pânico	O próprio ataque e o próximo ataque	1 mês após um ataque
Agorafobia	Situações das quais é difícil escapar ou receber ajuda	6 meses
TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada)	Múltiplos aspectos da vida	6 meses
Induzido por substância ou condição médica	Ex.: cafeína	Variável

3. Transtorno de ansiedade generalizada

Essência: preocupação (expectativa apreensiva) excessiva, na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, sobre diversos eventos, desproporcional à probabilidade ou ao impacto real, difícil de controlar e que invade a atenção às tarefas, mesmo quando o paciente a reconhece como excessiva.

3 ou mais sintomas associados, mnemônico "TIC FIS M" ("o TIC do ansioso FISga a Mente"):

- **T**ensão muscular persistente
- **I**rritabilidade
- **C**oncentração difícil ou "branco" na mente
- **F**atigabilidade pelo desgaste mental
- **I**nquietação, "nervos à flor da pele"
- **S**ono perturbado, inclusive preocupação com o próprio ato de dormir

- **M**emória de trabalho comprometida

Importância diagnóstica. Os sintomas precisam ser buscados ativamente, o atraso diagnóstico pode chegar a 10 anos, sintomas isolados não fecham o diagnóstico e a preocupação tem de ser generalizada.

Comorbidades: hipertensão, doença cardiovascular, dor crônica, condições gástricas (eixo cérebro e intestino) e, sobretudo, TDM. Avalie os critérios de cada um separadamente; se nenhum se completa, considere transtorno misto ansioso e depressivo.

4. Tratamento do TAG

Guiado pelo impacto funcional e emocional; sem prejuízo relevante, pode ser só psicoterapia.

Gravidade	Conduta
Leve	TCC isolada
Moderada	TCC, fármaco ou ambos
Grave	TCC obrigatoriamente associada a fármaco

TCC e medicação isoladas têm eficácia semelhante; a associação é a mais eficaz. **Reavalie em 4 a 6 semanas.**

TCC no TAG: a preocupação é o alvo; identificam-se desencadeantes, perpetuadores, prejuízos e estratégias de enfrentamento; enfrentam-se ativamente os perpetuadores; faz-se psicoeducação; treina-se relaxamento muscular progressivo, exposição e mindfulness; medem-se resultados com escalas; previne-se recaída pelo uso contínuo das habilidades.

Farmacológico:

- Primeira linha: ISRS (escitalopram, sertralina, paroxetina).
- IRSN (Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina): venlafaxina e duloxetina.
- Pregabalina em casos selecionados.

5. Pregabalina: mecanismo completo

É análogo estrutural do GABA (ácido gama-aminobutírico), mas **não age em receptores GABA**. Liga-se à subunidade α2δ dos canais de cálcio voltagem dependentes no terminal pré-sináptico. Com menos cálcio entrando, menos vesículas se fundem à membrana e cai

a liberação de neurotransmissores excitatórios (glutamato, noradrenalina e substância P). Resultado: menos hiperexcitabilidade neuronal.

Circuito da ansiedade. Na ansiedade a amígdala está hiperativada, o hipocampo registra memórias emocionais em excesso e o córtex pré-frontal perde a capacidade de frear a amígdala. A pregabalina reduz a atividade da amígdala, modula a ínsula (percepção emocional e interocepção) e atua no hipocampo, restaurando o equilíbrio.

Uso prático: duas tomadas diárias; boa biodisponibilidade e absorção rápida; sem metabolismo hepático relevante, com excreção renal, exigindo ajuste na insuficiência renal. Efeitos dose dependentes: tontura e sonolência (os mais comuns), quedas em idosos, edema de membros inferiores (menos frequente) e ganho de peso em doses altas. Age mais rápido que ISRS e IRSN, é alternativa na intolerância ou falha dos antidepressivos e não atua nos sistemas serotoninérgico ou noradrenérgico.

Macete "PREGA o cálcio": a pregabalina prega a porta do canal de cálcio e o neurônio para de disparar.

6. Buspirona

Agonista parcial do receptor 5-HT1A (serotonina tipo 1A). Com o tempo, dessensibiliza os autorreceptores pré-sinápticos e aumenta progressivamente a atividade serotoninérgica. Não atua em GABA, não tem efeito imediato (não serve de resgate) e leva semanas para agir. Exige 2 a 3 tomadas por dia, o que prejudica adesão e custo, mas é útil em quem tende a usar mal medicamentos, porque quase não causa dependência, sedação ou prejuízo cognitivo. Tem leve efeito antidepressivo (adjuvante) e trata bruxismo, principalmente o induzido por ISRS. **Tem baixa eficácia no pânico.**

7. Benzodiazepínicos (BZD)

Mecanismo. Ligam-se a um sítio alostérico do receptor GABA-A, diferente do sítio do GABA (ação não competitiva), e potencializam o GABA: o canal de cloro abre com mais frequência, o cloro entra, a membrana hiperpolariza e o neurônio fica menos excitável. O resultado é depressão global do SNC (Sistema Nervoso Central).

Subunidade do GABA-A	Efeito
α1	Hipnótico e sedativo, maior risco de dependência (zolpidem age aqui, é essencialmente hipnótico)
α2 e α3	Ansiolítico
α5	Sedação, relaxamento muscular, prejuízo cognitivo

Macete: "1 dorme, 2 e 3 acalmam, 5 esquece". A tolerância se desenvolve sobretudo ao efeito sedativo.

Efeitos clínicos, mnemônico "ASRAA": Ansiolítico, Sedativo e hipnótico, Relaxante muscular, Anticonvulsivante, Amnésia anterógrada.

Perfis:

- Ansiolíticos: clonazepam, alprazolam.
- Hipnóticos: midazolam, flunitrazepam.
- Anticonvulsivantes: clobazam (menos sedação) e diazepam, que penetra rapidamente a BHE (Barreira Hematoencefálica) e serve para crises convulsivas e abstinência alcoólica.
- **Lorazepam:** metabolizado por conjugação direta, sem fase oxidativa hepática relevante, por isso preferido na disfunção hepática.

Riscos: dependência, tolerância e abstinência; sedação, prejuízo cognitivo e quedas no idoso; depressão respiratória em doses altas ou com outros depressores. **Uso por curto prazo.**

Insônia: latência do sono de até 30 minutos é normal; o zolpidem induz o sono, sem efeito ansiolítico relevante.

8. Dicas da prática no TAG

- O antidepressivo começa devagar e pode piorar a ansiedade no início, porque a disponibilidade de neurotransmissor sobe antes que os receptores se dessensibilizem; o efeito pleno exige a infrarregulação.
- Trate a insônia desde o início, separando insônia verdadeira de dificuldade de relaxar. BZD em dose baixa e por pouco tempo (alprazolam, clonazepam) ajuda; pregabalina funciona mesmo em dose baixa.
- Pregabalina com ISRS na resposta parcial: sintomas físicos persistentes, piora do bruxismo ou impossibilidade de subir o ISRS por efeitos adversos. Cautela no idoso.
- Venlafaxina: não comece com dose alta; alguns pacientes não toleram o efeito noradrenérgico e precisam voltar a um ISRS; a retirada tem mais síndrome de descontinuação.
- Buspirona: várias tomadas; boa para quem se adapta a doses fracionadas.

Manutenção: recaída de cerca de 20% em quem mantém o tratamento e de cerca de 50% em quem suspende. Mantenha por no mínimo 6 meses, de preferência 12, **sem reduzir a dose**, pois a dose da manutenção define o risco de recaída.

Retirada ou recaída? Retirada surge nos primeiros dias após reduzir ou suspender; recaída surge após semanas, com retorno dos sintomas originais. **Macete: "dias = droga saindo; semanas = doença voltando".**

9. Ataque de pânico

Surto abrupto de medo ou desconforto intenso, com pico em minutos e **4 ou mais sintomas**. Não é exclusivo do transtorno de pânico; pode ocorrer em outros transtornos (vira especificador) ou isolado.

Os 14 sintomas, agrupados por sistema (macete "CORAÇÃO, PULMÃO, BARRIGA, NERVOS E MEDO"):

- **Coração:** palpitações ou taquicardia; dor ou desconforto torácico.
- **Pulmão:** falta de ar ou sufocamento; sensação de asfixia.
- **Barriga:** náusea ou desconforto abdominal.
- **Nervos autonômicos:** tontura, vertigem ou sensação de desmaio; sudorese; calafrios ou ondas de calor; tremores; parestesias.
- **Mente:** desrealização (ambiente estranho, sons distantes); despersonalização (fora do próprio corpo).
- **Medo:** de perder o controle ou "enlouquecer"; de morrer.

Critérios clínicos. Menos de 4 sintomas é crise de ansiedade, não ataque completo. Dura em média 40 minutos a 1 hora; sintomas além disso são ativação autonômica residual. Sem intensidade marcante e desespero, é ansiedade, não pânico.

Exclua sempre causa orgânica no atendimento agudo, mnemônico "CIRMIA": Cardio (angina, IAM, Infarto Agudo do Miocárdio), Infecções, Respiratório (asma, embolia pulmonar), Metabólico (hipo ou hiperglicemia), Intoxicação (cafeína, drogas), Abstinência (álcool, BZD).

10. Transtorno de pânico

1. **Ataques recorrentes e inesperados** (pode haver ataques com gatilho, mas obrigatoriamente alguns inesperados).
2. O paciente não retorna à tranquilidade entre as crises.
3. **Pelo menos 1 ataque seguido, por 1 mês ou mais**, de apreensão persistente com novos ataques ou suas consequências (perder o controle, infartar, enlouquecer) e/ou mudança comportamental desadaptativa, como esquiva de exercício, de dirigir ou de lugares.

O foco da preocupação é o próprio ataque; a incerteza sobre o próximo gera hipervigilância e ansiedade antecipatória. **Base neurobiológica:** hiperativação das áreas de alerta, com processamento constante de informações internas (interoceptivas) que mantém as crises.

Tratamento farmacológico:

- Primeira linha: ISRS; entre os IRSN, venlafaxina.
- BZD (alprazolam, clonazepam), sobretudo no início; lorazepam tem menos evidência específica.
- ADT (Antidepressivos Tricíclicos): imipramina e clomipramina também são eficazes.
- Buspirona: baixa eficácia.
- Pregabalina: considerar se não houver sintomas depressivos.
- Psicoterapia mais medicação é a primeira linha, apesar de custo e acesso.

Dicas: comece o antidepressivo em dose muito baixa e avise sobre a piora inicial. BZD fixo no início se crises muito frequentes; como resgate se espaçadas (o paciente costuma carregá-lo como segurança); sempre deixe claro o caráter sintomático e temporário.

TCC no pânico (evidência robusta): o alvo é a **esquiva**, não eliminar a emoção; mostre que o prejuízo da esquiva é maior que o desconforto da crise. Planeje a crise (onde parar o carro), use relaxamento e distração (nomear objetos ao redor), aumente a tolerância às sensações e faça exposição gradual para desconfirmar as expectativas catastróficas.

Descontinuação somente com remissão completa: nenhuma crise, nem leve; funcionalidade plena por pelo menos 1 ano; manejo de situações sem precisar interromper crises com frequência; paciente seguro para a retirada. A recaída é alta e menor em quem mantém psicoterapia.

11. Agorafobia

Isolada ou com pânico. **Medo marcante em 2 ou mais das 5 situações, por pelo menos 6 meses. Mnemônico "AT FFS" ("ATeu Fica Fora Sozinho")**: espaços Abertos, Transporte público, locais Fechados, Filas ou multidões, Sair de casa Sozinho.

O núcleo é o pensamento de que será difícil escapar ou não haverá ajuda. As situações quase sempre provocam medo imediato, são evitadas ativamente, exigem acompanhante ou são suportadas com intenso sofrimento, de forma desproporcional ao perigo real. Tratamento: medicação ajuda, mas a **terapia de exposição gradual** é fundamental. **No idoso**, verifique se o medo não é de risco real de queda ou limitação física, para não errar o diagnóstico.

12. Transtorno de ansiedade social

Medo acentuado em situações em que pode ser avaliado: interação (conversar, conhecer pessoas), observação (comer ou beber em público) e desempenho (falar em público). As situações são evitadas ou suportadas com medo intenso de agir mal ou mostrar sintomas e ser humilhado, rejeitado ou ofender alguém. **O foco central é a avaliação negativa.** Forma-se um ciclo: o medo leva à esquiva, que mantém o transtorno. **Macete "IOD": Interação, Observação, Desempenho.**

Tratamento: TCC como abordagem principal, com psicoeducação, relaxamento muscular progressivo, treino de habilidades sociais, exposição gradual imaginária e ao vivo, feedback por vídeo para corrigir a percepção distorcida do desempenho e reestruturação cognitiva. Antidepressivos são a primeira linha farmacológica, como nos outros ansiosos.

13. Fobia específica

Medo acentuado, persistente e desproporcional a objeto ou situação, com resposta quase sempre imediata (sintomas autonômicos, pânico situacional, fuga), esquiva persistente ou enfrentamento com intenso sofrimento, **por pelo menos 6 meses**. O paciente geralmente reconhece o exagero, mas não o controla.

Especificadores, mnemônico "ANSSO": Animais; ambientes Naturais (altura, água, tempestade, escuro); Sangue, injeção e ferimentos; Situacional (avião, elevador, túnel, transporte); Outro (engasgar, vomitar, sons altos).

Tratamento: terapia de exposição, primeira linha.

- **Hierarquia de exposição:** do menos ao mais ansiogênico (fotos, vídeos, aproximação, contato direto), repetida até a habituação.
- **Flooding:** exposição intensa e prolongada desde o início; mais rápida, porém muito mais ansiogênica.
- **Fobia de sangue, injeção e ferimentos:** pode haver resposta vasovagal com queda da pressão e síncope; exponha com o paciente deitado.
- **Mecanismo:** aprendizado inibitório, em que o córtex ganha controle sobre a amígdala e reduz o medo condicionado.

Não há fármaco específico eficaz; medicamentos tratam apenas as comorbidades.

Aula 8. Transtorno obsessivo compulsivo e espectro

O TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) é mantido por um ciclo de reforço negativo, em que o ritual alivia a ansiedade e confirma a crença de que evitou a catástrofe. O tratamento ideal associa TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) na forma de exposição com prevenção de resposta a ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina) em

doses altas por 12 a 20 semanas. A prevalência é de 1% a 3%, com atraso médio de 17 anos entre os sintomas e o tratamento adequado, porque o paciente usa serviços de saúde mas raramente consulta por esses sintomas.

1. O espectro obsessivo compulsivo

- **TOC:** obsessões, compulsões ou ambas, com impacto funcional.
- **Transtorno dismórfico corporal:** preocupação distorcida com defeitos de aparência imperceptíveis aos outros.
- **Transtorno de acumulação:** dificuldade persistente de descartar objetos, que congestionam os ambientes.
- **Tricotilomania:** arrancar cabelos, com tensão antes e alívio depois.
- **Transtorno de escoriação:** cutucar a pele causando lesões.
- **Induzido por substância:** anfetaminas, cocaína, estimulantes e clozapina.
- **Ciúme obsessivo:** pensamentos intrusivos de infidelidade sem base real.
- **Transtorno de referência olfativa:** crença de exalar odor desagradável sem confirmação.

Mnemônico "TODA TECIDO": TOC, Dismórfico, Acumulação, Tricotilomania, Escoriação, Ciúme, Induzido, Odor.

2. Obsessões

Pensamentos, impulsos (vontade súbita de ato inapropriado ou perigoso) ou imagens (cenas vívidas e perturbadoras) que invadem a consciência de forma automática. São recorrentes e persistentes, intrusivas, **egodistônicas** (contrárias aos próprios valores), geram ansiedade intensa e são reconhecidas como produto da própria mente, embora difíceis de controlar.

Pensamento intrusivo normal ou obsessão? Pensamentos intrusivos são universais, breves e descartados como irrelevantes. No TOC o pensamento recebe uma interpretação distorcida, como algo importante, perigoso ou moralmente inaceitável. A sequência patológica:

1. Pensamento intrusivo inicial.
2. Atribuição de importância exagerada.
3. Transformação em obsessão persistente.
4. Aumento de ansiedade e emoções negativas.
5. Tentativas de neutralizar, suprimir ou controlar, que falham e aumentam ainda mais a frequência e a intensidade do pensamento (efeito rebote da supressão mental).

Macete: "Não pense num elefante rosa": quanto mais tenta não pensar, mais pensa.

3. Compulsões e o mecanismo de manutenção

Comportamentos repetitivos (lavar, verificar, acender e apagar a luz) ou atos mentais (rezar, contar, repetir palavras) feitos para reduzir ansiedade ou prevenir um evento temido, com sensação de obrigação e regras rígidas (número exato, ordem exata). Podem responder a uma obsessão ("minha mãe vai morrer", então apaga e acende a luz) ou existir sem obsessão clara (entrar e sair pela porta repetidas vezes).

Reforço negativo, o motor do TOC. O ritual retira o desconforto (estado aversivo); a retirada de algo aversivo é reforço negativo, que fortalece o comportamento. Como a catástrofe não ocorre, o cérebro conclui que foi o ritual que a evitou, a crença disfuncional se fortalece e as obsessões e compulsões aumentam em ciclo vicioso.

Três apresentações do ciclo:

- **Obsessão mais compulsão:** obsessão, ansiedade, compulsão, alívio temporário; a não ocorrência do evento retroalimenta.
- **Só obsessão:** obsessão, ansiedade, tentativa de distração ou supressão, alívio momentâneo e retorno mais intenso.
- **Só compulsão:** ansiedade sem obsessão identificável, compulsão, alívio imediato, dependência progressiva do ritual.

4. Critérios diagnósticos do TOC

- **A.** Obsessões, compulsões ou ambas; o paciente tenta neutralizá-las, sem sucesso; as compulsões visam reduzir ansiedade ou prevenir o temido, com alívio temporário.
- **B.** Consomem tempo significativo ou causam sofrimento ou prejuízo. Se deixar de fazer o ritual não gera sofrimento relevante, não é TOC (relevância clínica: não consegue dormir sem o ritual).
- **C.** Não são efeito de substância (sintomas só durante uso de estimulantes não são TOC primário).
- **D.** Não são mais bem explicados por psicose, ansiedade específica ou transtorno do humor.

Especificador de insight (vale também para dismórfico e acumulação): bom ou razoável (reconhece que as crenças provavelmente não são verdadeiras); pobre (acha que provavelmente são verdadeiras); ausente com crenças delirantes (convicção absoluta).

5. Padrões clínicos mais comuns

Padrão	Obsessão	Compulsão	Detalhe de prova
Contaminação	Sujeira, germes, fezes, urina, poeira; crê que a contaminação se espalha por contato mínimo	Lavagem, banhos longos, limpeza	A evitação alivia no curto prazo, mas impede a habituação
Dúvida patológica	Ter falhado em tarefa cotidiana	Verificação de portas, fogão, janelas; voltar várias vezes para casa	Intolerância à incerteza
Pensamentos intrusivos predominantes	Temas agressivos, sexuais ou moralmente inaceitáveis	Compulsões mentais (rezar, repetir)	Pouco perceptível externamente; efeito rebote
Simetria e ordem	Exatidão, alinhamento, "justo"	Organizar e repetir até "sentir que está certo"	Pode gerar lentidão patológica; busca completude interna, não prevenir catástrofe

Macete "CDPS": Contaminação, Dúvida, Pensamentos, Simetria.

6. Curso

Início mais precoce em meninos (infância) e em meninas (adolescência); cerca de 25% começam até os 14 anos; início após os 35 é incomum e pede investigação de diferenciais. O início é geralmente insidioso, mas pode ser agudo após estressor. O curso é predominantemente crônico, às vezes episódico, e uma minoria se deteriora progressivamente.

7. Neurobiologia

A alteração central é **menos inibição e mais excitação**: os gânglios da base falham como filtro dos estímulos corticais e pensamentos irrelevantes chegam à consciência de forma persistente. **Mnemônico "S↓ D↑ G↑": Serotonina baixa, Dopamina alta, Glutamato alto.**

- **Hipótese serotoninérgica (hipofunção):** sem serotonina para inibir os circuitos córtico estriatais, tálamo e estriado ficam hiperativos e as obsessões e compulsões persistem.
- **Hipótese dopaminérgica (hiperfunção):** a dopamina regula a valorização de estímulos e o aprendizado por reforço; em excesso, supervaloriza sinais de erro, ameaça ou incompletude e cria a necessidade de corrigi-los, reforçando a repetição.
- **Hipótese glutamatérgica (hiperatividade):** o glutamato, principal excitatório do SNC (Sistema Nervoso Central), gera hiperexcitabilidade e vence os mecanismos inibitórios.

Cada hipótese tem seu tratamento correspondente: ISRS para a serotonina, antipsicótico para a dopamina, memantina e lamotrigina para o glutamato.

8. Comorbidades e suicídio

Comorbidade é a regra, em até 90% dos casos, incluindo dismórfico, tricotilomania e escoriação. **Suicídio:** cerca de 36% têm ideação, 20% planejam e 11% tentam. **Fatores de risco:** obsessões sexuais ou religiosas (homossexualidade, incesto, temas religiosos, com intensa culpa), uso de substâncias e transtornos do controle de impulsos.

9. Tratamento

Princípios:

- Psicoterapia mais medicação é o ideal.
- Psicoeducação do paciente e da família, orientando sobre a **acomodação familiar**: quando a família adapta a rotina ao ritual (todos tiram o sapato para o paciente não se angustiar), perpetua o sintoma.
- A procura é baixa por estigma e medo de "loucura".
- Remissão completa é incomum (10% a 20%); o usual é melhora parcial.

Exposição com prevenção de resposta. Forma de TCC que quebra o ciclo. O remédio reduz ansiedade e intensidade das obsessões, mas a melhora sustentada depende de **não fazer a compulsão**: o cérebro precisa aprender que a ansiedade cai sozinha, sem ritual.

- **Com compulsões:** expõe-se ao gatilho e impede-se a resposta. A ansiedade sobe no início e depois cai espontaneamente (habituação). A exposição é gradual e pode ser hierárquica: quem checa 10 vezes passa a 9, depois menos, até extinguir. É essencial impedir a **substituição de compulsões** (parar de checar mas repetir em voz alta que trancou).
- **Só obsessões:** o paciente se expõe ao pensamento sem suprimir e o desenvolve até o fim. Diante de "vou me jogar na frente do carro", completa o raciocínio, reconhece que o desfecho seria morrer e que isso não é seu desejo. Isso desfaz a **fusão pensamento**

e ação, a crença de que pensar equivale a agir ou aumenta a chance de agir. **Macete: "pensar não é fazer".**

Farmacoterapia:

- **ISRS, primeira linha.** Todos têm evidência; citalopram e escitalopram não têm aprovação formal da FDA (Food and Drug Administration) para TOC, mas são usados. **Doses mais altas que em outros transtornos** (doses baixas são ineficazes; titular até a máxima tolerada), com **resposta em 12 a 20 semanas**; mesmo após atingir a dose máxima em cerca de 3 meses, a resposta ainda pode vir depois. Falta de melhora em poucas semanas não é falha.
- **Clomipramina:** ADT (Antidepressivo Tricíclico) fortemente serotoninérgico, de alta eficácia (alguns estudos a acham superior aos ISRS), limitada pelos efeitos anticolinérgicos e cardiotóxicos.
- **IRSN:** não aprovados para TOC e com menor evidência.
- **Antipsicótico adjuvante:** na resposta parcial ou refratariedade ao ISRS, para reduzir a hiperatividade dopaminérgica; os mais estudados são **risperidona e aripiprazol**, inclusive em crianças.
- **Abordagem glutamatérgica nos refratários:** memantina (antagonista NMDA, receptor N-metil-D-aspartato, que reduz a excitabilidade) e lamotrigina (moduladora glutamatérgica).

Macete da escada terapêutica: "S, C, A, G, C" = ISRS em dose alta, Clomipramina, Antipsicótico, Glutamatérgico, Cirurgia.

Tratamento invasivo: para casos graves e altamente resistentes, após falha de TCC associada a farmacoterapia adequada.

- Ablativos estereotáxicos: capsulotomia anterior (lesão bilateral da porção anterior da cápsula interna) e cingulotomia (porção anterior do giro do cíngulo), por termolesão com radiofrequência (termocapsulotomia) ou radiocirurgia com raios gama, Gamma Knife (radiocapsulotomia).
- Neuromodulação: estimulação cerebral profunda com eletrodos implantados; estimulação magnética transcraniana profunda, não invasiva.

10. Transtornos de tique

São transtornos do neurodesenvolvimento, distintos do TOC, mas o TOC tem o **especificador "relacionado a tique"** para história atual ou passada de tique, porque ambos compartilham os circuitos córtico estriatais e a hiperatividade dopaminérgica.

Curso: início entre 4 e 6 anos, geralmente com piscar intenso; pico de gravidade entre 10 e 12 anos; melhora na adolescência, com parte persistindo grave na vida adulta. Pioram com ansiedade, excitação e fadiga; melhoram em atividades calmas e concentradas. **Fatores de**

risco: pais mais velhos, eventos pré e perinatais, herdabilidade de 50% a 70% e genética compartilhada com TOC, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TEA (Transtorno do Espectro Autista).

- **Tourette:** múltiplos tiques motores e pelo menos 1 vocal, não necessariamente simultâneos, por mais de 1 ano, com início antes dos 18.
- **Tique motor ou vocal persistente:** só motor ou só vocal, mais de 1 ano, início antes dos 18.
- **Coprolalia:** emissão involuntária de palavras obscenas, de alta carga emocional e processadas no sistema límbico; a falha do controle inibitório somada à carga afetiva as libera, e quanto maior o constrangimento, maior a repetição. Ocorre em minoria dos casos.

Neurobiologia: hiperatividade dopaminérgica no estriado com falha da inibição GABAérgica (ácido gama-aminobutírico), liberando movimentos e vocalizações.

Macete "Tourette = Toca e Tosse": muitos tiques motores e ao menos um vocal.

11. Transtorno dismórfico corporal

- **A.** Preocupação intensa, intrusiva e difícil de controlar com defeitos não observáveis ou leves para terceiros.
- **B.** Comportamentos repetitivos (espelho, arrumar-se, beliscar a pele) ou atos mentais (comparar-se), que reduzem a ansiedade ou checam o defeito e mantêm o transtorno.
- **C.** Sofrimento ou prejuízo, com evitação social e queda de desempenho.
- **D.** Não explicado por transtorno alimentar: o foco **não** é peso ou gordura.

Tem especificador de insight. **Dismorfia muscular:** sentir-se pequeno ou pouco musculoso apesar de bom desenvolvimento, com treino excessivo, substâncias e dietas rígidas.

12. Transtorno de acumulação

- **A.** Dificuldade contínua de descartar objetos, ditada pelo valor subjetivo, não pelo real.
- **B.** Necessidade percebida de guardar e sofrimento intenso ao descartar (medo de perder algo útil).
- **C.** Acúmulo que congestiona e inutiliza ambientes (cama, cozinha, banheiro); se não há obstrução, geralmente é porque terceiros intervieram.
- **D.** Sofrimento ou prejuízo, com isolamento, conflitos e risco à saúde e segurança.
- **E.** Não explicado por lesão cerebral nem por TOC, depressão, esquizofrenia, TEA ou demência.

O insight frequentemente é ausente. Prevalência de 2% a 6%, mais evidente acima de 55 anos, quando se deve diferenciar de transtorno neurocognitivo maior. **Linha do tempo "15, 20, 30":** surge entre 15 e 19 anos, interfere por volta dos 20, causa prejuízo significativo em torno dos 30; curso crônico e progressivo. Tratamento semelhante ao TOC; o prognóstico do espectro em geral não é bom.

13. Tricotilomania

- **A.** Arrancar cabelos (couro cabeludo, sobrancelhas, cílios) com alopecia irregular.
- **B.** Tentativas repetidas de parar.
- **C.** Sofrimento ou prejuízo, com vergonha e tentativa de esconder as falhas.
- **D.** Não explicada por doença dermatológica, TOC ou dismórfico.

Relações: prevalência de 15,3% no TDAH contra 2,5% na população geral, apontando para circuitos de impulsividade e controle inibitório; estimulantes não mudam a gravidade de forma consistente e podem causar rebote ao fim do efeito. É mais frequente no TOC e em parentes de primeiro grau, mas difere dele por não depender de obsessões: é impulso ou hábito, automático ou focado, com insight preservado. Pode lesar o folículo de forma irreversível e, raramente, haver tricofagia (ingestão dos fios).

Tratamento: terapia de reversão de hábitos (identificar gatilhos, aumentar a consciência e substituir por resposta incompatível e inofensiva, como apertar um objeto ou fechar as mãos); N-acetilcisteína acima de 2 g por dia, moduladora glutamatérgica que reduz a impulsividade, promissora mas com estudos pequenos; ISRS em dose alta têm baixa eficácia; clomipramina com evidência limitada; antipsicóticos pouco eficazes.

14. Transtorno de escoriação

- **A.** Escoriação recorrente com lesões visíveis (rosto, braços, mãos), de superficiais a profundas, com risco de infecção e cicatriz.
- **B.** Tentativas repetidas de parar.
- **C.** Sofrimento ou prejuízo, com vergonha e isolamento.
- **D.** Não explicado por escabiose, dermatoses, síndrome de Ekbom (delírio de parasitose) ou dismórfico.

Pode ser automático ou focado; costuma haver tensão, desconforto cutâneo ou imperfeição percebida antes, alívio depois e, em seguida, culpa. É mantido por reforço negativo e se assemelha à tricotilomania. **Tratamento:** TCC com reversão de hábitos (mãos ocupadas, barreiras físicas); N-acetilcisteína com evidência limitada; outros fármacos em casos selecionados.

Macete final do espectro: "Tricotilo e Escoriação = hábito, Reversão e NAC (N-acetilcisteína); TOC = obsessão, Exposição e ISRS alto".

Aula 9. Transtornos relacionados a trauma e estressores

Neste capítulo a exposição a um evento traumático ou estressante é critério diagnóstico explícito. O TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático) se trata principalmente com psicoterapia de exposição e ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina), e a regra de ouro farmacológica é **não usar benzodiazepínicos no primeiro mês após o trauma**.

1. Transtornos da infância: a falha do apego

O desenvolvimento normal exige um cuidador consistente, previsível e responsivo. Sem ele, a criança não aprende a confiar nem a regular emoções. Formas de negligência: privação social (falta de afeto, contato e estímulo), trocas repetidas de cuidadores (sem tempo para vínculo estável) e instituições inadequadas (muitos cuidadores, pouca interação individual, sem apego seletivo). Da mesma falha nascem duas respostas opostas:

Característica	Transtorno de apego reativo	Transtorno de interação social desinibida
Padrão	Inibido, retraído, pouco responsivo	Excessivamente familiar com estranhos
Núcleo	Falha em formar apego seletivo seguro: "o outro não me protege"	Ausência de filtro social: "qualquer adulto serve"
Comportamento	Aflita, raramente busca conforto; responde pouco quando consolada; irritabilidade, tristeza ou medo inexplicados	Aproximação física inadequada, conversas íntimas, sai com desconhecidos sem resistência
Frequência entre gravemente negligenciadas	Menos de 10%	Cerca de 20%
Diferencial principal	TEA (Transtorno do Espectro Autista): no apego reativo há negligência clara; no TEA o déficit é neurobiológico	TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade): persiste sem hiperatividade nem desatenção
Outros pontos	Início antes dos 5 anos; raro; pode persistir anos	Raro; aumenta vulnerabilidade social; sintomas podem durar até a adolescência

Característica	Transtorno de apego reativo	Transtorno de interação social desinibida
Tratamento	Psicoterapia e, sobretudo, cuidador estável, previsível e responsivo	Psicoterapia, ambiente estável, limites sociais e vínculos seletivos

Macete: "Reativo Recua; Desinibido se Doa a qualquer um".

2. TEPT: os cinco critérios

Mnemônico "E I E H H" com números, "1 Evento, 1 Intrusão, 1 Esquiva, 2 Humor, 2 Hiper":

1. **Exposição** a morte real ou ameaçada, lesão grave ou violência sexual.
2. **Intrusivos:** 1 ou mais.
3. **Esquiva:** 1 ou ambas as formas.
4. **Humor e cognição:** 2 ou mais.
5. **Hiper-reatividade:** 2 ou mais.

Critério 1: exposição. A gravidade objetiva do evento é essencial; estressores menores com sintomas parecidos são transtorno de adaptação ou resposta persistente ao trauma. Formas de exposição: viver o evento; testemunhá-lo presencialmente; saber que ocorreu com familiar ou amigo próximo, de forma súbita ou violenta; exposição repetida ou extrema a detalhes aversivos (socorristas que recolhem restos humanos, policiais expostos a detalhes de abuso infantil).

Critério 2: intrusivos. Surgem porque a memória do trauma não foi processada e permanece ativa, fragmentada e altamente emocional.

- Lembranças intrusivas involuntárias, vívidas, disparadas por gatilhos.
- Sonhos angustiantes frequentes, com o mesmo conteúdo emocional, mesmo sem reproduzir o evento.
- Flashbacks (reações dissociativas): sente ou age como se o evento ocorresse de novo, "volta no tempo"; menos comuns, indicam maior gravidade.
- Sofrimento intenso diante de gatilhos externos (lugares, sons, cheiros) ou internos (pensamentos, emoções), que leva à esquiva.
- Reações fisiológicas intensas: taquicardia, dispneia, sudorese, tremor, pânico, uma resposta de luta ou fuga sem perigo real.

Critério 3: esquiva. De recordações, pensamentos e sentimentos, e/ou de estímulos externos (pessoas, lugares, conversas, objetos).

Critério 4: humor e cognição (2 ou mais), mnemônico "A CREDO":

- **A**mnésia dissociativa de aspectos importantes do evento
- **C**ognições distorcidas sobre causa ou consequência, com culpa de si ou de terceiros
- **R**edução do interesse em atividades significativas
- **E**stado emocional negativo persistente (medo, raiva, culpa, vergonha)
- **D**escrença no mundo: crenças negativas exageradas sobre si, os outros e o mundo
- **O**s afetos positivos não aparecem (incapacidade persistente de sentir felicidade, satisfação, amor)

Critério 5: hiper-reatividade (2 ou mais), mnemônico "HIPER S": Hipervigilância; Irritabilidade e surtos de raiva; Prudência perdida (comportamento imprudente ou autodestrutivo); Espanto exagerado (sobressalto); Raciocinar mal (concentração); Sono perturbado.

Temporalidade. O estresse agudo aumenta o risco, mas não é obrigatório para o TEPT.

Fatores de risco: adversidade na infância, transtorno mental prévio e personalidade vulnerável; baixa resiliência e enfrentamento limitado; falta de suporte sociofamiliar; sexo feminino e juventude; maior gravidade do evento (ameaça à vida, lesão pessoal).

3. TEPT complexo e resposta persistente ao trauma

TEPT complexo (CID-11, Classificação Internacional de Doenças, 11ª revisão; não consta no DSM). Exposição prolongada ou repetida a eventos extremos dos quais é difícil escapar: tortura, escravidão, genocídio, violência doméstica crônica, abuso físico ou sexual repetido na infância. Exige todos os critérios do TEPT mais desregulação emocional, autoimagem negativa persistente (inferior, derrotado, com vergonha e culpa), prejuízo nas relações e impacto funcional amplo. Tem pior prognóstico, tratamento mais longo e a psicoterapia ganha papel ainda mais central. **Macete "DAR" a mais: Desregulação, Autoimagem, Relações.**

Resposta persistente ao trauma. Classificada como Outro Transtorno Relacionado a Trauma e Estressores Especificado: sintomas relevantes, mas insuficientes para TEPT completo (o "TEPT parcial ou subclínico"), com sofrimento e prejuízo que justificam tratamento.

4. Tratamento do TEPT: psicoterapia

Primeira linha, com foco em corrigir culpa, vergonha e desconfiança e extinguir o medo condicionado.

Base do trauma: medo mais evitação. A estrutura do medo une estímulos que lembram o trauma, respostas fisiológicas (taquicardia, sudorese, hipervigilância), pensamentos de perigo e interpretações catastróficas, com dissociação entre razão e emoção ("sei que

não há perigo, mas sinto pavor"). A evitação impede a exposição; sem exposição o cérebro não reaprende que o estímulo é seguro, e o medo condicionado se mantém.

Terapia de exposição prolongada (primeira escolha, maior evidência). Etapas:

1. Psicoeducação sobre o TEPT e o papel da evitação.
2. Treino de respiração para autorregulação.
3. Exposição in vivo com hierarquia.
4. Exposição imaginária com revivência detalhada.
5. Revisão e processamento, reavaliando crenças.
6. Aprendizado inibitório, com novas associações não ameaçadoras.

O abandono é alto, de 30% a 35%.

Outras psicoterapias:

- **Processamento cognitivo:** alta evidência; identifica, questiona e reformula crenças sobre o trauma.
- **Exposição escrita:** cinco sessões com psicoeducação, relato em primeira pessoa, leitura, reescrita com mais detalhes e sentimentos, revisão final.
- **EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares):** estimulação bilateral que facilita o processamento adaptativo da memória.

5. Tratamento do TEPT: farmacologia

ISRS: primeira escolha, para ansiedade, humor e reexperiência.

Por que não usar BZD (benzodiazepínicos) no primeiro mês. Além do maior risco de abuso no TEPT, há um paradoxo fisiopatológico. No trauma ocorre um pico de cortisol que ativa a luta ou fuga e participa do processamento inicial da memória; em pessoas sem vulnerabilidade genética, o cortisol se autorregula depois. O BZD apaga a resposta autonômica e a ansiedade consciente, mas não o substrato neurobiológico do estresse. Sem resposta emocional proporcional, a memória não é processada de forma adaptativa e sofre **hiperconsolidação no hipocampo**, aumentando o risco de TEPT. **Macete: "BZD cala o alarme, mas grava o incêndio".**

Bloqueio adrenérgico. A hiperatividade noradrenérgica reforça a formação de memórias aversivas; bloqueá-la reduz a hiperconsolidação.

- **Alfa 1 (doxazosina; prazosina, de maior evidência, não disponível no Brasil):** pesadelos e sintomas noturnos e intrusivos, por dessensibilização autonômica no sono e menor hiperexcitação límbica.
- **Beta (propranolol):** hiper-reatividade.

Macete: "Alfa para o sonho, Beta para o susto".

Terapia assistida por MDMA (metilenodioximetanfetamina). Só em ambiente terapêutico controlado; experimental no Brasil, uso compassivo em alguns países, em aprovação nos Estados Unidos e aprovada na Austrália para prescritores autorizados. Mecanismo: liberação intensa de serotonina, além de dopamina e noradrenalina, abrindo uma janela de neuroplasticidade; a memória traumática é ativada em segurança, o medo diminui pelo aumento de serotonina e a memória é reconsolidada de forma mais adaptativa.

Estresse agudo: para a insônia, evite BZD e prefira quetiapina, trazodona, anti-histamínicos ou antipsicóticos de baixa potência; doxazosina e prazosina ajudam intrusivos e sono.

6. Transtorno de adaptação

- **A.** Sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a estressor identificável, **iniciados em até 3 meses**.
- **B.** Clinicamente significativos: sofrimento desproporcional ao estressor e/ou prejuízo funcional.
- Não preenche outro transtorno nem é exacerbação de um preexistente; não é luto normal.
- **Cessado o estressor e suas consequências, os sintomas não duram mais de 6 meses.**

Macete "3 para entrar, 6 para sair".

Especificadores: com humor deprimido; com ansiedade; misto de ansiedade e humor deprimido; com perturbação da conduta; com perturbação mista das emoções e da conduta; não especificado. **Duração:** agudo (menos de 6 meses) ou persistente (6 meses ou mais, usado quando o estressor ou suas consequências continuam presentes).

Tratamento: psicoterapia, rotina e higiene do sono; fármacos conforme o perfil de sintomas, sem boa evidência para nenhum específico.

7. Transtorno do luto prolongado

Incluído como diagnóstico formal em 2022 (DSM-5-TR).

- **A.** Após morte de pessoa próxima, há pelo menos **12 meses em adultos e 6 meses em crianças e adolescentes**.
- **B.** Na maioria dos dias do último mês, 1 ou ambos: saudade intensa; preocupação com pensamentos e memórias do falecido (em crianças, com as circunstâncias da morte).
- **C.** 3 ou mais, **mnemônico "IDE ADA SS"**: perturbação da Identidade (parte de si morreu junto); Descrença na morte; Evitação de lembranças que confirmem a morte; Angustia emocional intensa (raiva, amargura, tristeza); Dificuldade de reintegração às

atividades e relações; Apatia; perda de Sentido da vida; Solidão intensa.

- **D.** Sofrimento ou prejuízo.
- **E.** Duração e intensidade excedem claramente as normas culturais, sociais ou religiosas.
- **F.** Não explicado por outro transtorno nem por substância.

Epidemiologia: prevalência incerta, estudos sugerem 10% a 18% com baixa confiabilidade; risco elevado de ideação suicida, maior em morte violenta e morte de filho com menos de 25 anos. **Fatores de risco:** alta dependência emocional do falecido, morte de criança, morte violenta ou inesperada, estressores econômicos, perda de cônjuge ou filho. **Diferenciais:** TDM e TEPT.

Terapia do luto prolongado de Katherine Shear (Universidade Columbia). Integra exposição prolongada, reestruturação cognitiva e ativação comportamental para reduzir a evitação da perda e devolver a funcionalidade. São cerca de 16 sessões semanais de 45 a 60 minutos, em quatro fases:

1. **Avaliação e psicoeducação:** história da perda, fatores de risco, plano individual, normalização das reações, adaptação saudável versus luto disfuncional.
2. **Exposição:** relato detalhado da morte no tempo presente, gravado em sessão e ouvido em casa repetidamente, dessensibilizando e integrando as memórias.
3. **Ativação comportamental:** metas concretas, retomada de atividades e da vida social, ocupacional e pessoal, restauração de papéis e identidade.
4. **Integração:** carta ao falecido e visita imaginária, expressão de sentimentos não ditos e da ambivalência, aceitação da morte, reintegração das lembranças positivas, vínculo simbólico, revisão dos ganhos e novos projetos de vida.

Macete das fases: "Entender, Reviver, Reagir, Ressignificar". Farmacoterapia apenas como suporte, sobretudo em comorbidades; não há evidência robusta para o luto prolongado isolado.

Aula 10. Transtornos somatoformes e dissociativos

Nos transtornos somatoformes o sofrimento psíquico se expressa no corpo (psíquico para somático); nos dissociativos há perda da integração entre funções psíquicas (psíquico para psíquico). Em ambos o tratamento central é psicoeducação cuidadosa e psicoterapia; os fármacos servem às comorbidades.

1. Mapa dos quadros somáticos

Quadro	Núcleo	Intenção consciente?	Ganho externo?
Sintomas somáticos	Sintoma físico com pensamentos, ansiedade e tempo excessivos	Não	Não
Ansiedade de doença	Medo de ter ou contrair doença grave, sintomas mínimos ou ausentes	Não	Não
Conversivo (sintomas neurológicos funcionais)	Sintoma motor ou sensorial incompatível com a neurologia	Não	Não (só ganho secundário inconsciente)
Factício (Munchausen)	Falsifica ou induz doença para ocupar o papel de doente	Sim	Não
Simulação (não é transtorno)	Produz sintomas	Sim	Sim (dinheiro, afastamento, absolvição)

Macete das duas perguntas: "É de propósito? Para ganhar algo lá fora?". Não e não = somatoforme ou conversivo; sim e não = factício; sim e sim = simulação.

2. Transtorno de sintomas somáticos

Somatização é a presença de queixas físicas múltiplas, em vários sistemas, sem explicação orgânica e de origem psicogênica. Só é transtorno quando há sofrimento e prejuízo.

- **A.** 1 ou mais sintomas somáticos que causam aflição ou prejuízo significativo.
- **B.** Pelo menos 1 de: pensamentos persistentes e desproporcionais sobre a gravidade; ansiedade elevada e contínua com a saúde; tempo e energia excessivos dedicados aos sintomas. **Macete "PAT": Pensamento, Ansiedade, Tempo.**

Quadro clínico: sintomas persistentes com busca repetida de consultas e exames mesmo após resultados normais; foco num órgão, mas sintomas que podem ser múltiplos e migratórios; alívio transitório após consultas e rápida volta da preocupação (semelhante ao TOC, com intrusivos sobre doença e checagem); curso crônico e flutuante.

Quando suspeitar: baixa plausibilidade biológica (diagnóstico de exclusão), falha terapêutica repetida e prejuízo desproporcional ao sintoma. **Fatores de risco:** exposição precoce a doenças graves (próprias ou familiares), baixo nível socioeconômico, adversidades na infância. **Perpetuadores:** família que reforça o papel de doente (reasseguramento constante, superproteção, assumir responsabilidades, levar ao médico a cada queixa).

Doença orgânica pode coexistir. O paciente com gastrite tratada com IBP (Inibidor da Bomba de Prótons) que mantém dor pode ter persistência funcional, componente somático ou ambos. Evite tanto a hiperinvestigação quanto a subvalorização.

Tratamento: psicoeducação sem invalidar (cuidado com a palavra "psicológico"); TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) como principal abordagem; consultas regulares e programadas com exame físico, que reduzem ansiedade e mostram que a queixa é valorizada; evitar exames invasivos e desnecessários e ter cautela com achados incidentais, que perpetuam a preocupação; ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina) como adjuvantes.

3. Transtorno de ansiedade de doença

O elemento central é o **medo da doença**, não o sintoma. Pode ser difícil diferenciar do TOC de temática hipocondríaca.

- **A.** Preocupação persistente em ter ou contrair doença grave.
- **B.** Sintomas físicos ausentes ou mínimos; se há condição médica, a preocupação é desproporcional.
- **C.** Ansiedade elevada com a saúde; alarma-se com sensações normais.
- **D.** Comportamentos excessivos (checar o corpo, múltiplas consultas) ou evitação mal adaptativa (evitar médicos e exames por medo da confirmação).
- **E.** Pelo menos 6 meses, podendo mudar a doença temida.

Subtipos: busca de cuidado (consultas e exames repetidos, aferir PA, Pressão Arterial, a toda hora) e evitação de cuidado (medo irracional de procurar atendimento).

Tratamento: psicoeducação, TCC como escolha, ISRS adjuvante. Consultas frequentes são **controversas**: ajudam alguns e reforçam a preocupação em outros, pois o paciente tem dificuldade de aceitar a ausência de doença.

Diferença de prova: no somático, "o sintoma me preocupa"; na ansiedade de doença, "a doença que posso ter me apavora".

4. Transtorno de sintomas neurológicos funcionais (conversivo)

Conversão: o conflito psíquico se manifesta como sintoma neurológico motor ou sensorial sem base orgânica. É diagnóstico de exclusão.

- **A.** 1 ou mais sintomas de função motora ou sensorial (fraqueza, paralisia, marcha, crises não epilépticas, anestesia).
- **B.** Incompatibilidade entre os achados e os padrões neurológicos conhecidos.
- **C.** Não explicado por outro transtorno ou condição (catatonia da esquizofrenia não é conversão; desmaio só nas crises de pânico é pânico).
- **D.** Sofrimento, prejuízo ou necessidade frequente de avaliação médica.

Tipos de sintoma, mnemônico "FRAMES DCM": Fraqueza ou paralisia; movimentos anormais (tremor, distonia, mioclonia, marcha); deglutição; fala (disfonia, disartria); crises não epilépticas; anestesia ou perda sensorial fora dos dermátomos; sentidos especiais (visão, audição, olfato); misto.

Pontos críticos:

- Exames normais **não** bastam para excluir causa orgânica; o diagnóstico exige achado clínico positivo de incompatibilidade. Sintomas "bizarros" também não excluem doença neurológica.
- Evite viés contra pacientes com transtorno mental.
- **Conversão não é simulação:** os sintomas são involuntários.

Epidemiologia: cerca de 1 em 10.000 pessoas; cerca de 4% dos atendimentos de neurologia; mais em mulheres jovens. **Comorbidades:** transtornos psiquiátricos em cerca de 90% (depressão, personalidade, ansiedade) e epilepsia verdadeira em cerca de 10%. **Perpetuadores:** ganhos secundários inconscientes, acomodação familiar, esquiva, comorbidades não tratadas e iatrogenia (excesso de exames, diagnósticos errados).

CNEP (Crise Não Epiléptica Psicogênica). Crises sem atividade elétrica compatível no EEG (eletroencefalograma), importante diferencial de epilepsia. Achados sugestivos, que sugerem mas não excluem, **mnemônico "QUADRIL FECHADO"**:

- Movimento amplo de **quadril**
- Movimentos **variáveis** e não estereotipados
- Opistótono, às vezes atípico
- **Olhos fortemente fechados** (na epilepsia geralmente ficam abertos)
- **Gritos no meio** da crise (vocalização inicial pode ser epiléptica)
- **Duração prolongada**
- Incontinência possível, não exclusiva da epilepsia
- **Pós ictal atípico**, muito breve ou muito longo

Diagnóstico: vídeo EEG é o padrão ouro, com validação pelo familiar de que a crise registrada é a habitual; lembre que o paciente pode ser sugestionável e ter crise durante o exame.

Etiologia:

- **Modelo psicanalítico:** conflito entre impulso instintivo (agressividade, sexualidade) e a proibição de expressá-lo; a ansiedade é reprimida e convertida em sintoma simbólico que alivia a tensão (vaginismo como evitação inconsciente de desejo sexual inaceitável).
- **Modelo neurobiológico:** falha de integração entre sistema límbico (emoção) e sistemas motores e sensoriais voluntários. Emoção intensa, trauma ou ameaça disparam inibição funcional, não estrutural, de vias motoras ou sensoriais, por isso os exames são normais.

Conceitos:

- **Ganho primário:** alívio inconsciente do conflito; é o que gera o sintoma.
- **Ganho secundário:** vantagens externas do papel de doente (atenção, afastamento); mantém o sintoma, sem intenção consciente.
- **La belle indifférence:** tranquilidade aparente diante de sintoma grave; sugestiva, não obrigatória nem critério. Déficits parciais e inconsistentes também aumentam a suspeita.
- **Identificação:** o paciente modela o sintoma em pessoa significativa, como no luto, reproduzindo sintomas do falecido.

Macete: "primário PRODUZ, secundário SUSTENTA".

Tratamento: psicoeducação sem dizer "é psicológico" ou "não é nada"; explicar que os sintomas são reais, decorrentes de alteração funcional e não de lesão. Psicoterapia como estratégia principal, avaliando as contingências do sintoma (evitar situações, expressar emoções, comunicar necessidades) e ampliando o repertório emocional. Não há remédio que elimine o sintoma; fármacos só para comorbidades.

5. Transtorno factício (síndrome de Munchausen)

- **A.** Falsificação intencional de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos, ou indução de doença, com **fraude comprovada** (não registre no prontuário por mera suspeita).
- **B.** Apresenta-se deliberadamente como doente.
- **C.** Sem recompensa externa evidente, por necessidade psicológica do papel de doente, podendo até ter prejuízo.
- **D.** Não explicado por delírio ou psicose.

Há a **forma imposta a outro** (antes "por procuração"), em que o cuidador produz doença em quem está sob seus cuidados. Começa no adulto jovem, muitas vezes após uma hospitalização, com curso crônico e episódico.

Sinais de suspeição, mnemônico "DRAMA INSANO": quadro **D**ramático e incomum; **R**esistência ao tratamento convencional; **A**lergias múltiplas inconsistentes; **M**últiplas internações e cirurgias mal documentadas; **A**ntecipa a evolução clínica; **I**solamento social, poucas visitas; **N**ovos sintomas surgem quando outros melhoram; **S**aúde é sua área (profissionais e estudantes); **A**nseio por exames e procedimentos invasivos; **N**ega informações colaterais (contatos, prontuários); **O** quadro não segue padrões conhecidos.

Tratamento: não há terapia comprovada; prognóstico reservado. Foco em reduzir morbimortalidade por procedimentos e autolesões, abordar as necessidades psíquicas, atentar para questões éticas e legais (sobretudo na forma imposta a outro) e monitorar a **contratransferência** da equipe (inutilidade, perplexidade, culpa, hostilidade, desprezo).

6. Transtornos dissociativos: conceito

Dissociação é a perda da integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, percepção e comportamento, de forma parcial e variável (psíquico para psíquico). A identidade do eu depende da integração contínua dessas funções; nos dissociativos essa integração se rompe. Os três principais: transtorno dissociativo de identidade, amnésia dissociativa e despersonalização ou desrealização.

7. Transtorno dissociativo de identidade

Ruptura da identidade com 2 ou mais estados de personalidade. É controverso, com mais relatos nos Estados Unidos e poucos dados no Brasil; pode haver ganhos secundários sem implicar simulação.

- **A.** 2 ou mais estados distintos, com alterações de afeto, comportamento, consciência, memória, percepção, cognição e função sensoriomotora.
- **B.** Lacunas de memória recorrentes, incompatíveis com esquecimento comum: eventos cotidianos, dados pessoais, eventos traumáticos (encontra objetos que não lembra de ter comprado).
- **C.** Sofrimento ou prejuízo.
- **D.** Não explicado por prática cultural ou religiosa aceita (transe).
- **E.** Não atribuído a substância ou condição médica (crises parciais complexas).

Mecanismo proposto:

1. Trauma intenso e repetido na infância.
2. Hiperativação límbica com supressão do córtex pré-frontal, que perde a capacidade de integrar e elaborar.

3. Fragmentação de memórias e emoções em redes neurais parcialmente segregadas.
4. Inibição cruzada: quando uma rede está ativa, as outras ficam inibidas.
5. Resultado: amnésia interidentitária; o paciente alterna sem perceber e volta sem lembrar.

As identidades podem ter sexo, idade e fala próprios, sem relação lógica entre si. A neuroimagem funcional mostra padrões distintos entre identidades que controles instruídos a simular não reproduzem. No campo forense a inimputabilidade é controversa.

Sugere simulação, mnemônico "ACOSI": Amnésia estereotipada sem sintomas sutis (depressão, sofrimento); **C**aricatura de identidades "boas" e "más"; **O**rgulho ou prazer com o transtorno; **S**eletividade conveniente da amnésia (evitar punição); **I**ncentivos externos (dinheiro, notoriedade, absolvição).

8. Amnésia dissociativa

Incapacidade de recordar informações autobiográficas importantes, geralmente traumáticas, por **bloqueio de acesso** (não é dúvida nem esquecimento comum). Tipos: localizada (um período, em geral o do trauma), generalizada (toda a história, rara e grave) e seletiva (parte do período). Pode ser isolada ou associada a TEPT. A capacidade de formar novas memórias costuma estar preservada; na forma generalizada pode falhar e simular quadro orgânico.

Os dois casos clínicos da aula:

Aspecto	Acidente de moto (trauma físico agudo)	Agressão física e sexual (trauma interpessoal)
Instalação	Imediata e circunscrita	Retardada, dias depois, progressiva
Por que não é orgânico	Capacete, sem TCE (Traumatismo Cranioencefálico) relevante, sem perda de consciência, funções neurológicas preservadas, déficit só de memória	Agiu e pediu ajuda no momento; o bloqueio surge ao iniciar o processamento consciente
Achado típico	Amnésia retrógrada circunscrita; reconhece familiaridade sem lembrar (implícita preservada, explícita bloqueada)	Afeto dissociado: não lembra, mas mantém depressão e déficit de atenção

Fuga dissociativa (especificador). Viagem aparentemente proposital ou perambulação sem rumo com amnésia da identidade, geralmente com amnésia generalizada, uma "fuga do eu". Dura horas a meses; o paciente pode assumir nova identidade e viver

funcionalmente; ao terminar, volta abruptamente à identidade original sem lembrar o período, às vezes em local desconhecido. O diagnóstico é retrospectivo.

Diferenciais: neurológicos (epilepsia, AVC, Acidente Vascular Cerebral, AIT, Ataque Isquêmico Transitório, TCE, amnésia global transitória, que dura até 24 horas); substâncias gabaérgicas (BZD, zolpidem, álcool) e quetamina; sonambulismo; outros transtornos (dissociativo de identidade, conversivo, factício); simulação. Investigue com neuroimagem, EEG, laboratório e, se indicado, LCR (Líquido Cefalorraquidiano), sem sub nem hiperinvestigar.

Tratamento: psicoeducação e ambiente seguro e estável. Hipnose é controversa e de baixa evidência: pode trazer memórias traumáticas sem preparo e criar falsas memórias em sugestionáveis. Psicoterapia como principal estratégia, com ou sem foco em recuperar a memória, que **não é obrigatória** para melhorar; se a memória voltar, ajude a dar sentido ao trauma, resolver problemas do episódio e seguir em frente. Fármacos só para comorbidades.

9. Transtorno de despersonalização e desrealização

- **Desrealização:** o **mundo** parece irreal, distante ou modificado (vozes distantes, objetos com tamanho alterado), sem alteração sensorial orgânica.
- **Despersonalização:** o **eu** parece estranho; sensação de sair do corpo e se observar de fora.

Em ambas o juízo de realidade está preservado: o paciente sabe que a experiência não é real. **Macete: "DesREALização = o mundo real some; desPERSONAlização = a pessoa some".**

Fatores de risco: estressores agudos ou crônicos; depressão, ansiedade e transtornos de personalidade; SPA (Substâncias Psicoativas); luto intenso.

Modelo neurobiológico. Diante de ansiedade intensa, o organismo entra em hiperativação e hipervigilância e, ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal inibe a resposta emocional. A emoção se desliga da consciência, e surgem juntos: ausência súbita de reatividade emocional, menos sensações corporais e mente "vazia". É um freio de emergência emocional que deixa o alarme ligado.

Diferenciais: epilepsia focal, intoxicação gabaérgica (álcool, BZD, zolpidem), excesso de ISRS, ataque de pânico (irrealidade secundária à hiperativação), aura de enxaqueca e crises focais.

Tratamento: psicoeducação; TCC como primeira linha; hipnose com cautela; ISRS quando há ansiedade ou depressão (tratar as comorbidades é fundamental); lamotrigina em sintomas dissociativos persistentes.

Aula 11. Transtornos de personalidade

Transtorno de personalidade é um padrão mal adaptativo, rígido e inflexível de pensar, sentir e se relacionar, iniciado no fim da adolescência ou início da vida adulta, que causa prejuízo funcional e sofrimento. São 10 transtornos em 3 clusters, e o tratamento principal é psicoterápico; os fármacos tratam apenas sintomas e comorbidades.

1. Conceitos de base

- **Temperamento:** componente inato, com tendências biológicas e emocionais presentes desde cedo.
- **Personalidade:** padrões recorrentes e persistentes de comportamento, pensamento e emoção na relação com o mundo, moldados por cultura, experiências e relações.
- **Traço:** característica adaptativa e **flexível**, que se ajusta ao contexto (o reservado que socializa quando precisa).
- **Transtorno:** padrão **rígido**, duradouro e mal adaptativo.

Macete: traço dobra, transtorno quebra.

Modelo dos 5 fatores (Big Five), mnemônico "OCEAN": Openness, abertura à experiência (criatividade, curiosidade, flexibilidade cognitiva); **C**onscientiousness, conscienciosidade (organização, disciplina, controle de impulsos); **E**xtraversion, extroversão (sociabilidade, assertividade, busca de estímulos sociais); **A**greeableness, amabilidade (empatia, cooperação, altruísmo); **N**euroticism, neuroticismo (instabilidade emocional, ansiedade, irritabilidade, vulnerabilidade ao sofrimento).

2. Os três clusters

Cluster	Perfil	Transtornos	Mnemônico
A	Esquisitos ou excêntricos	Paranoide, esquizoide, esquizotípico	"A = Alienados, Weird": PEE
B	Dramáticos, emotivos ou instáveis	Antissocial, borderline, histriônico, narcisista	"B = Barulhentos": ABHN
C	Ansiosos ou medrosos	Evitativo, dependente, obsessivo compulsivo	"C = Covardes": EDO

Macete clássico: A = Weird (estranho), B = Wild (selvagem), C = Worried (preocupado).

3. Cluster A

Comportamentos esquisitos e excêntricos, distanciamento social e interpretações peculiares da realidade.

Paranoide. Desconfiança e suspeita difusas: os outros vão explorá-lo, prejudicá-lo ou enganá-lo sem evidência; ações neutras viram ameaças. Não confia, não compartilha informações pessoais por medo de que sejam usadas contra ele, vive hipervigilante, guarda rancor e não perdoa, discute e se defende muito, interpreta comentários comuns como ataques. **Diferencial:** em geral não tem sintomas psicóticos persistentes, o que o separa do transtorno delirante e da esquizofrenia.

Esquizoide. Distanciamento das relações e expressão emocional restrita; prefere atividades solitárias, não deseja vínculos nem intimidade emocional ou sexual, não se satisfaz em grupos nem na família, é indiferente a crítica e elogio. O afeto é achatado, não apenas hipomodulado. Pode render bem em trabalhos isolados. Sob estresse intenso pode ter psicose breve de minutos a horas, e pode ser antecedente pré mórbido de esquizofrenia ou transtorno delirante. **Diferença do TEA (Transtorno do Espectro Autista):** no esquizoide há desinteresse genuíno pelas relações; no TEA pode haver desejo de interagir, com dificuldade de comunicação e reciprocidade. Exemplo da aula: Wandinha Addams.

Esquizotípico. Déficits sociais com desconforto nas relações próximas, distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidade (roupas, fala, interesses). O isolamento vem da estranheza e da ansiedade social, que **persiste mesmo após familiarização**. Tem ideias de referência sem intensidade delirante, crenças incomuns (clarividência, telepatia, controle mágico), pensamento mágico ou excessivamente abstrato. Sob estresse pode ter psicose transitória e até preencher critério psicótico. É do espectro esquizofrênico: mais prevalente em parentes de primeiro grau de esquizofrênicos, e vice versa. Exemplo da aula: Willy Wonka.

Macete "Paranoide desconfia, Esquizoide se isola por gosto, Esquizotípico se isola por estranheza".

4. Cluster B

Impulsividade, instabilidade emocional e relações intensas ou conflituosas.

Antissocial. Indiferença e violação dos direitos alheios sem remorso; não se ajusta às normas, mente, é impulsivo, irritável, agressivo e irresponsável. **Tem empatia cognitiva (entende o que o outro sente) mas déficit de empatia emocional.** Não é necessariamente "mau" deliberado: prioriza os próprios objetivos e passa por cima de quem for obstáculo, íntimo ou estranho, embora alguns sejam cruéis. É manipulador, convincente e superficialmente charmoso, usando fragilidades alheias de forma instrumental.

- **Neurobiologia:** alterações no córtex pré-frontal e na amígdala impedem formar representações de medo antecipatório e de eventos aversivos; por isso não aprende com punição e repete o comportamento mesmo após prisão.
- **Epidemiologia:** 0,6% a 3,6% (DSM-5-TR); até cerca de 70% em ambientes forenses; também presente em posições de liderança; forte componente genético.

Narcisista. Grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Superestima capacidades, exagera conquistas, desvaloriza os outros, parece arrogante, mas tem **autoestima frágil** dependente de validação externa. Diante de crítica reage com desdém, fúria ou contra-ataque, rebaixando quem o criticou; não tolera que alguém seja melhor. Exemplo da aula: Miranda, de O Diabo Veste Prada.

Narcisista ou antissocial? Ambos desconsideram os outros, mas o antissocial busca **vantagem própria** sem se importar com o dano, e o narcisista busca **sentir-se superior e admirado**.

Histriônico. Emocionalidade excessiva e busca persistente de atenção; precisa ser o centro, mesmo de forma negativa. É dramático e teatral, pode ser sedutor ou provocativo, usa a aparência, assume papéis ("vítima", "princesa") e considera as relações mais íntimas do que são. Adapta-se ao que der mais atenção (doença, humor, espontaneidade) e, se perde o foco, exagera, inventa, cria conflitos. As emoções são superficiais e mutáveis. Difere do antissocial: não busca ganho instrumental, busca atenção.

Borderline. Instabilidade das relações, da autoimagem e dos afetos, com impulsividade acentuada. **O núcleo é o medo irreal e desproporcional de abandono**, real ou imaginado, que leva a esforços desesperados (automutilação, ameaças suicidas, impulsividade). Tem intensa reatividade emocional; impulsividade em gastos, sexo, substâncias, direção, compulsões e automutilação; explosões seguidas de vergonha e culpa; vazio crônico; autossabotagem; dissociação sob estresse. Alterna **idealização e desvalorização**: o outro passa de perfeito a cruel quando falta atenção, e pequenos afastamentos viram abandono.

Ciclo do borderline:

1. Medo intenso de abandono ou rejeição.
2. Ansiedade, desespero e sofrimento.
3. Impulsividade para aliviar a dor ou evitar o abandono.
4. Conflitos e instabilidade das relações.
5. Culpa, vergonha e arrependimento.
6. Medo de ter afastado as pessoas.
7. Reinício do ciclo.

Macete do cluster B pelo "o que querem": Antissocial quer VANTAGEM; Narcisista quer ADMIRAÇÃO; Histriônico quer ATENÇÃO; Borderline quer NÃO SER ABANDONADO.

5. Cluster C

Ansiedade, insegurança e comportamento evitativo ou dependente.

Evitativo. Inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa; tímido, quieto, socialmente "invisível" por medo de rejeição, humilhação ou crítica. Funciona como ansiedade social ampliada a quase toda a vida; o "mundo ideal" seria ser invisível. Sente-se incapaz, pouco atraente e inferior; **deseja vínculos**, mas só se aproxima com grande certeza de aceitação. A postura tensa pode atrair atenção negativa e deboche, reforçando a crença de inadequação e o ciclo de esquiva.

Dependente. Necessidade excessiva de ser cuidado, com submissão, apego e medo de separação. Sente-se incapaz de funcionar sozinho, não decide sem conselho (até roupas e compras), delega a outros áreas inteiras da vida, concorda com o que acha errado para não perder apoio e teme parecer competente, pois isso poderia afastar quem cuida. Ao delegar, não desenvolve habilidades e perpetua a dependência. **Diferença do borderline:** no borderline o medo é de abandono afetivo, de não ser amado; no dependente é de não conseguir funcionar sem cuidado.

Obsessivo compulsivo (de personalidade). Preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal; atenção a regras, listas e cronogramas a ponto de perder o objetivo; o perfeccionismo impede concluir tarefas. Dedicação excessiva ao trabalho não explicada por necessidade financeira, lazer escasso ou rígido, dificuldade de delegar, respeito literal à autoridade e sofrimento diante de ambiguidade ou falta de regras. Costuma ser avarento, guardando dinheiro para catástrofes futuras. Muitos percebem a própria rigidez e sofrem ao tentar flexibilizar.

Macete do cluster C pelo medo: Evitativo teme a CRÍTICA; Dependente teme FICAR SEM CUIDADO; Obsessivo teme PERDER O CONTROLE.

6. Tratamento

Princípio: o tratamento principal é psicoterápico; a farmacoterapia tem efeito limitado sobre a estrutura da personalidade e serve ao controle sintomático e às comorbidades.

Cluster ou transtorno	Farmacológico	Psicoterapia
Cluster A	Antipsicóticos para desconfiança, distorções perceptivas, pensamento excêntrico, psicose transitória (evidência limitada)	Não detalhada na aula
Antissocial	Sem eficácia no transtorno; antipsicóticos ou estabilizadores (ácido valproico) para agressividade, impulsividade, irritabilidade	Sem eficácia comprovada em adultos; mais chance com intervenção precoce no transtorno de conduta antes dos 15 anos; vínculo difícil
Narcisista	Não detalhado	Evidência escassa; desvaloriza o terapeuta, resiste e abandona
Histriônico	Não detalhado	Sem evidência robusta
Borderline	Pouca ou nenhuma eficácia no transtorno; uso sintomático pelo menor tempo possível (antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores)	**TCD (Terapia Comportamental Dialética): forte evidência**; reduz impulsividade, automutilação, suicídio, instabilidade e conflitos
Cluster C	ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina) reduzem ansiedade no evitativo; sem benefício consistente no dependente e no obsessivo	Melhores evidências de resposta à psicoterapia

Detalhes do borderline:

- **Ômega 3:** cerca de 2 g por dia, com mais EPA (ácido eicosapentaenoico) que DHA (ácido docosa-hexaenoico), pode ajudar sintomas depressivos e suicidalidade; evidência baixa.
- **Lisdexanfetamina:** um estudo sugeriu melhora, mas o borderline frequentemente tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) ou sintomas parecidos (impulsividade, desregulação, disforia à rejeição); a melhora pode ser do TDAH. Não é evidência robusta.
- **Benzodiazepínicos: NÃO.** Alto risco de abuso, dependência e piora da impulsividade; o borderline tende a usar substâncias para aliviar o sofrimento.

Psicanálise: sem estudos robustos de eficácia nos transtornos de personalidade, o que não significa ausência de benefício, mas falta de evidência padronizada.

Macete final: "A toma antipsicótico, B borderline faz TCD e nunca BZD, C responde à terapia e o evitativo ao ISRS".

Aula 12. Transtornos alimentares

Os transtornos alimentares são os transtornos psiquiátricos de maior repercussão clínica sistêmica, com alta morbimortalidade por desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos e alterações cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas e metabólicas. São mais comuns em mulheres (adolescentes e adultas jovens), mas crescem em homens, e o paciente muitas vezes procura atendimento pela complicação clínica, não pela queixa psiquiátrica. Sinais de alerta: perda ponderal importante, distorção da imagem corporal, restrição, compulsão, vômitos autoinduzidos, amenorreia, abuso de laxantes ou diuréticos e preocupação excessiva com peso e forma.

1. Comparativo central

Aspecto	AN (Anorexia Nervosa)	BN (Bulimia Nervosa)	TCAP (Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica)
Núcleo	"Não comer": restrição e medo de engordar	Ciclo compulsão mais compensação	Perda de controle sem compensação
Peso	Baixo (exceto atípica)	Normal, sobrepeso, oscilações	Metade não é obesa
Frequência mínima	Sem critério de frequência; subtipo pelos últimos 3 meses	1 vez por semana por 3 meses	1 vez por semana por 3 meses
Gravidade	IMC (Índice de Massa Corporal)	Comportamentos compensatórios por semana	Episódios de compulsão por semana
Proporção mulher para homem	10:1	10:1	3:1
Fármaco aprovado pela FDA (Food and Drug Administration)	Nenhum; olanzapina é a mais usada	Fluoxetina	Lisdexanfetamina

Aspecto	AN (Anorexia Nervosa)	BN (Bulimia Nervosa)	TCAP (Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica)
Psicoterapia de escolha	TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) focada; terapia familiar em jovens	TCC, padrão ouro	TCC ou interpessoal, individual ou em grupo

Macete dos fármacos aprovados: "Bulimia FLUi, Compulsão LISa, Anorexia OLHA (olanzapina) sem aprovação".

2. Anorexia nervosa: critérios

- **A.** Restrição calórica com baixo peso significativo para idade, sexo, desenvolvimento e saúde.
- **B.** Medo intenso de ganhar peso, mesmo com baixo peso, ou comportamento persistente que impede o ganho (restrição extrema, exercício, jejum, vômitos, laxantes, diuréticos).
- **C.** Perturbação da imagem corporal: peso e forma dominam a autoavaliação, e a gravidade do estado nutricional não é reconhecida.

Macete "RMI": Restrição, Medo, Imagem.

Gravidade pelo IMC:

Gravidade	IMC (kg/m²)
Leve	17 ou mais
Moderada	16 a 16,99
Grave	15 a 15,99
Extrema	Menos de 15

Macete "17, 16, 15": cada ponto a menos sobe um degrau. O IMC tem limitações: uma paciente previamente obesa pode perder muito peso, restringir gravemente e ter repercussões sem IMC baixo. Avalie também a restrição, a velocidade da perda, as repercussões orgânicas e a gravidade psiquiátrica; ainda assim, IMC baixo segue sendo marcador de risco cardiovascular, metabólico e de mortalidade.

Subtipos (últimos 3 meses):

- **Restritivo:** sem compulsão recorrente nem purgação; perde peso por restrição, jejum e exercício.
- **Compulsão alimentar purgativa:** compulsão recorrente ou purgação (vômitos, laxantes, diuréticos, jejum ou exercício compensatórios). O DSM usa "ou": a purgação pode ocorrer sem compulsão, mesmo em quem quase não come. Vômito isolado não define bulimia; na AN o núcleo continua sendo o medo de comer e a restrição.

Anorexia atípica. Preenche todos os critérios, exceto o baixo peso: o IMC fica normal ou alto porque o peso prévio era elevado, mesmo com grande perda em pouco tempo. O "corpo normal" atrasa o diagnóstico, mas as complicações podem ser tão graves quanto na forma clássica; o risco se mede pela restrição, velocidade da perda e repercussões, não pelo IMC.

3. Anorexia: clínica e neuromodulação

Clínica: a suspeita costuma vir antes de a paciente reconhecer o problema. Dietas extremamente restritivas e exclusão de grupos alimentares, inclusive disfarçadas de "saudáveis" (jejum intermitente excessivo, dietas de redes sociais, obsessão por comida "limpa"); rituais (cortar em pedaços minúsculos, comer devagar, separar alimentos, evitar refeições compartilhadas); interesse exagerado por culinária; isolamento social; sintomas depressivos, obsessivos, rigidez e perfeccionismo; pesagem, medição e checagem frequentes; roupas largas ou em camadas. Sinais de purgação: ir ao banheiro logo após comer, laxantes ou diuréticos escondidos, exercício após comer, jejuns compensatórios.

Neuromodulação: a anorexia não é falta de fome. "An" = ausência e "orexis" = apetite, mas o nome é impróprio: a paciente sente fome. O problema é como o cérebro interpreta a fome, que vira ameaça à magreza e ao controle, e a resposta alimentar é inibida voluntariamente. Para quem não tem o transtorno, comer gera prazer, saciedade e alívio; na AN gera culpa, ansiedade, perda de controle e medo de engordar. Essas emoções reforçam a restrição, que passa a significar controle e segurança. **Ciclo:** fome, medo de engordar, restrição, sensação de controle, reforço da restrição.

4. Anorexia: epidemiologia, risco e comorbidades

Transtorno grave com mortalidade elevada por desnutrição, complicações cardiovasculares e metabólicas e suicídio. Mais em mulheres jovens (10:1), historicamente de classe média e alta, e em ambientes que valorizam a magreza (moda, dança, ginástica) ou famílias com foco na aparência e comentários precoces sobre peso. Prevalência relativamente baixa, o que limita os estudos.

Genética: herdabilidade de 50% a 60% (participação de componentes genéticos, não transmissão familiar obrigatória); parentes de primeiro grau têm risco cerca de 10 vezes maior. Genes candidatos envolvem serotonina, dopamina, sistema opioide, regulação do

apetite e do peso, BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro) e estrógeno.
Personalidade: rigidez comportamental e cognitiva, perfeccionismo e atenção excessiva a detalhes.

Comorbidades: abuso de substâncias 60%, transtornos do humor 55%, álcool 49%, ansiedade 40%, espectro obsessivo compulsivo 28%.

5. Anorexia: repercussões sistêmicas

Sistema	Achados
Hematológico	Anemia normocítica normocrômica, ferropriva ou macrocítica (B12 e folato); leucopenia
Eletrólitos	Hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia (repercussão cardíaca e no ECG, eletrocardiograma); hipofosfatemia, ligada à síndrome de realimentação
Ósseo	Osteopenia e osteoporose por desnutrição e hipoestrogenismo
Endócrino	Amenorreia secundária por hipogonadismo hipogonadotrófico funcional; quadro semelhante a hipotireoidismo por adaptação metabólica
Gastrointestinal	Constipação e gastroparesia, porque menos comida significa menos estímulo à motilidade
Cardíaco (até 80%)	Distúrbios de condução, QT longo, baixa voltagem do QRS, alterações de ST, menor massa ventricular esquerda, menor débito, disfunção diastólica com sintomas de insuficiência cardíaca, derrame pericárdico

O coração sofre porque a desnutrição consome também o músculo cardíaco (catabolismo). **A maioria das complicações é reversível com a recuperação nutricional.**

6. Síndrome de realimentação: mecanismo completo

Ocorre em quem restringiu muito e é realimentado rapidamente, em geral por volta do quarto dia.

1. Na desnutrição, o corpo esgota os estoques intracelulares de fósforo, potássio e magnésio, embora os níveis séricos possam parecer normais.
2. A reintrodução de carboidratos eleva a insulina.

3. A insulina faz as células captarem glicose e, junto, eletrólitos; o metabolismo celular acelera e consome fosfato (para ATP, adenosina trifosfato).
4. Fósforo, potássio e magnésio migram para dentro das células e despencam no sangue.
5. **A hipofosfatemia é a alteração mais característica:** fraqueza muscular, insuficiência respiratória, disfunção cardíaca e arritmias potencialmente fatais. Somam-se hipocalemia, hipomagnesemia e alterações no ECG.
6. A realimentação reduz a excreção renal de sódio e água, com retenção hídrica: edema periférico e pulmonar, sobrecarga volêmica e descompensação cardíaca no coração já enfraquecido.
7. Pode haver hiperglicemia.
8. A falta de tiamina diante do aumento brusco do metabolismo da glicose pode desencadear **encefalopatia de Wernicke**.

Macete "FPM + TIA": Fósforo, Potássio e Magnésio caem; TIAmina falta.

Reabilitação nutricional: iniciar com 5 a 20 kcal/kg/dia, conforme a gravidade e o risco, e monitorar com frequência fósforo, potássio, magnésio, sódio, glicemia, estado volêmico e ECG.

7. Anorexia: tratamento

Objetivos: normalizar o peso; restabelecer padrões alimentares; reduzir a percepção da comida como ameaça; corrigir a imagem corporal; manejar repercussões clínicas e psiquiátricas. A AN tem componentes cerebrais, metabólicos, psiquiátricos e comportamentais, por isso o tratamento é **obrigatoriamente multidisciplinar** (psiquiatria, psicologia, nutrição, clínica médica, enfermagem), com coordenação para evitar abordagens contraditórias.

Psicoterapia (parte central): TCC (reestruturação de crenças sobre peso, corpo e comida e mudança dos comportamentos restritivos e compensatórios); terapia interpessoal (relações e conflitos); terapia do esquema (experiências emocionais precoces); treino de habilidades sociais e regulação emocional. Psicoeducação individual e familiar.

Olanzapina: antipsicótico mais usado na AN, por promover ganho ponderal (pelo apetite e por efeitos metabólicos próprios) e reduzir sintomas obsessivos e ansiosos. Os estudos farmacológicos são poucos, curtos, pequenos e com vieses.

Diretrizes da APA (American Psychiatric Association):

- (1C) metas individualizadas de ganho de peso semanal e peso alvo.
- (1B) adultos: psicoterapia focada em transtorno alimentar, com normalização da alimentação, restauração do peso e abordagem do medo de engordar e da imagem corporal.

- (1B) adolescentes e adultos jovens com cuidador envolvido: terapia familiar focada, educando cuidadores para normalizar a alimentação e restaurar o peso.

Internação, mnemônico "DEIB CRIS": Desnutrição grave; **E**letrólitos muito alterados; **I**nstabilidade cardiovascular; **B**radicardia importante; **C**omplicações cardíacas; **R**isco de realimentação; **I**ncapacidade de se alimentar no ambulatório; **S**uicídio em risco elevado. A internação é curta, para estabilizar, seguida de hospital dia, ambulatório intensivo e terapia familiar; internação breve e longa têm eficácia semelhante.

Prognóstico: risco cardíaco, de mortalidade clínica e de suicídio, mas muitos se recuperam: 31,4% em 9 anos e 62,8% em 22 anos (metade dos não recuperados em 9 anos melhorou depois); outro estudo, 64%, com duração média de cerca de 10 anos e sem mortes na amostra. O curso é longo, com recaídas e remissões.

8. Transtorno de compulsão alimentar periódica

- **A.** Episódios recorrentes de compulsão: quantidade claramente maior do que a maioria comeria no mesmo período e circunstância, **com sensação de perda de controle**.
- **B.** 3 ou mais, **mnemônico "RÁPIDO, CHEIO, SEM FOME, SOZINHO, CULPADO"**: comer mais rápido que o normal; até ficar desconfortavelmente cheio; grandes quantidades sem fome física; sozinho por vergonha; desgosto, depressão ou culpa depois.
- **C.** Sofrimento marcante.
- **D.** Pelo menos 1 vez por semana por 3 meses.
- **E.** Sem comportamento compensatório e sem critérios de AN ou BN.

Gravidade (episódios por semana), igual à da bulimia: leve 1 a 3; moderada 4 a 7; grave 8 a 13; extrema 14 ou mais. **Macete "3, 7, 13, 14".** A validade é questionável, pois o número de episódios nem sempre acompanha sofrimento e prejuízo. Não exige obesidade, e pode ocorrer até com alimentos pouco calóricos: **o elemento central é a perda de controle.**

Epidemiologia: o transtorno alimentar mais prevalente; proporção 3:1; metade não é obesa; pode ser pródromo de outros transtornos alimentares; mais frequente entre quem busca emagrecer. **Antes da cirurgia bariátrica** é essencial investigar: a compulsão ativa é contraindicação relativa até estabilizar.

Características e abordagem: episódios secretos, com vergonha, culpa e constrangimento; subdiagnóstico e banalização como "falta de força de vontade". A psicoeducação mostra que é transtorno mental reconhecido e reduz a culpa. Evite termos pejorativos ("gordura", "obesidade" em tom depreciativo, "falta de força de vontade"); prefira peso, IMC, "comer sem fome", "perda de controle"; explicar os critérios facilita o relato.

Comorbidades: ansiedade, depressão, uso de substâncias, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade); risco de suicídio maior com depressão; comorbidades aumentam sofrimento, prejuízo, dificuldade terapêutica e recaída.

Sistema de recompensa. Mecanismos semelhantes às dependências: tolerância (episódios cada vez maiores, porque o sistema de recompensa se adapta e responde menos), sinais de abstinência (em ratos, agressividade, ansiedade e tremores após retirada de soluções ricas em glicose), fissura e recaídas frequentes.

O que não é compulsão:

Fenômeno	O que é	Por que não é TCAP
Comer hedônico	Comer por prazer, conforto ou recompensa; "comer as emoções", negativas ou positivas	Há escolha e consciência, sem perda de controle típica
Comer por impulso	"Curto-circuito da ação": ia comer um brigadeiro e comeu todos	Pode não haver grande quantidade, sofrimento persistente nem perda marcante de controle
Hiperfagia	Aumento do apetite e da ingestão (medicamentos, depressão atípica, hormônios, privação, ansiedade, neurológico)	Come mais com mais fome, sem perda de controle

Hedônico e impulsivo são os mais confundidos com TCAP e nem sempre respondem ao tratamento específico.

Outros quadros do DSM-5-TR: compulsão de baixa frequência ou duração limitada (menos de 1 vez por semana ou menos de 3 meses, ainda com sofrimento e prejuízo); **síndrome do comer noturno** (acorda para comer ou come muito após o jantar, **com consciência e lembrança** no dia seguinte, o que a diferencia da alimentação no sonambulismo; associada a insônia, ansiedade, humor, obesidade e desregulação circadiana).

9. Compulsão: tratamento

Estratégias: identificar gatilhos, que não são só emocionais (ambientes, disponibilidade de alimentos, rotina desorganizada, privação, situações sociais, emoções); evitar jejuns longos e dietas restritivas, que alimentam o ciclo **privação, fissura, compulsão, culpa, nova restrição**; acompanhamento nutricional com reeducação, horários regulares, nutrição comportamental, sinais de fome e saciedade e menos culpa; TCC com forte evidência.

Fissura alimentar. Desejo urgente de comer que dura em média cerca de **20 minutos**: sobe, atinge o pico e cai espontaneamente. Ensine o paciente a atravessar esse período com distração, mudança de ambiente, atividades incompatíveis com comer, regulação emocional e contato social. Suportar a fissura sem comer gera reforço positivo e enfraquece o ciclo. **Macete: "a onda dura 20 minutos; surfe, não mergulhe".**

Farmacológico (escolha guiada por comorbidades, perfil metabólico, risco cardiovascular, obesidade e sintomas):

Fármaco	Papel	Observações
Lisdexanfetamina	Único aprovado pela FDA para TCAP	Modula recompensa e controle inibitório; trata compulsão, impulsividade e perda de controle; não é para emagrecer quem não tem TCAP
Antidepressivos (fluoxetina, bupropiona)	Reduzem episódios via impulsividade, ansiedade e humor	Pouca eficácia para perda de peso
Topiramato	Reduz compulsão e peso; útil na obesidade	Efeitos cognitivos: lentificação, má concentração, memória, "embotamento"
Naltrexona com bupropiona	Aprovada para obesidade, não para TCAP; útil com obesidade, fissura e componente de recompensa	Melhor resultado: TCC com naltrexona e bupropiona; TCC isolada supera remédio isolado
Sibutramina	Papel secundário; aumenta noradrenalina, serotonina e dopamina	Risco cardiovascular, hipertensão, taquicardia; não aprovada para TCAP
Agonistas de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1)	Promissores, ainda não estabelecidos	Ver abaixo

GLP-1 e psiquiatria. Hipótese de reduzir "food noise" (pensamentos persistentes sobre comida), impulsividade, prazer excessivo e fissura, modulando recompensa, cognição e motivação, com potencial em adições e compulsão. Uma revisão narrativa de 10 estudos sugeriu benefício, quase todos em obesos. Limitações: estudos em obesidade e DM2 (diabetes melito tipo 2); farmacovigilância com depressão, ansiedade, insônia,

nervosismo, ideação suicida, autolesão e medo de comer, sem causalidade estabelecida, possivelmente ligados a perda rápida, vulnerabilidade prévia e restrição excessiva (alguns pacientes ingerindo 400 a 600 kcal por dia); esvaziamento gástrico lento que altera a absorção de medicamentos orais; falta de dados de longo prazo.

Diretrizes e linhas:

1. **Primeira linha:** TCC (ou interpessoal) individual ou em grupo, com eficácia semelhante (APA 1C).
2. **Segunda linha:** antidepressivos ou lisdexanfetamina para quem prefere remédio ou não respondeu à psicoterapia (APA 2C). Na prática, TCC mais remédio é o mais eficaz.
3. **Terceira linha e alternativas:** topiramato, naltrexona com bupropiona, sibutramina; GLP-1 ainda não estabelecido.

10. Bulimia nervosa

- **A.** Compulsão recorrente.
- **B.** Compensação inapropriada recorrente: vômitos, laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejum, exercício excessivo.
- **C.** Ambos pelo menos 1 vez por semana por 3 meses.
- **D.** Autoavaliação indevidamente influenciada por forma e peso.
- **E.** Não ocorre exclusivamente durante AN.

Gravidade (compensatórios por semana): leve 1 a 3; moderada 4 a 7; grave 8 a 13; extrema 14 ou mais. Proporção 10:1, início no fim da adolescência e início da vida adulta, frequentemente durante ou após dietas (privação, fissura, compulsão, compensação). Peso normal, sobrepeso ou oscilante. Curso crônico ou intermitente; os sintomas podem diminuir sem tratamento, mas o tratamento melhora muito a evolução; remissão maior que 1 ano indica melhor prognóstico, assim como diagnóstico precoce, abordagem multidisciplinar e manejo das comorbidades.

AN, BN e TCAP ao longo do tempo. Na AN predomina o "não comer", mesmo quando há compulsão e purgação; na BN a alimentação entre episódios é relativamente preservada. A passagem de BN para AN ocorre em 10% a 15%, com possíveis idas e voltas; a BN que perde os compensatórios vira TCAP. **O diagnóstico se baseia sempre nos últimos 3 meses.**

Outros quadros: transtorno de purgação (purga para controlar peso e forma **sem compulsão**); bulimia de baixa frequência ou duração limitada.

Consequências clínicas da purgação, com mecanismo:

- **Vômitos = alcalose metabólica**, pela perda de ácido clorídrico gástrico. **Laxantes = acidose metabólica**, pela perda de bicarbonato nas fezes. **Macete: "vomita ácido, fica alcalino; evacua base, fica ácido".**
- Erosão e desgaste do esmalte dentário pelo contato com ácido gástrico; hipertrofia bilateral de parótidas.
- Dependência funcional de laxantes, pela redução da motilidade intestinal fisiológica.
- **Hipocalemia, a principal alteração:** fraqueza, alterações de ECG e arritmias raras, mas potencialmente fatais.
- Mallory-Weiss (laceração esofágica) e ruptura gástrica: incomuns e de alta mortalidade.
- Irregularidade menstrual e amenorreia por oscilação de peso, deficiências, estresse fisiológico e sofrimento.

Tratamento: multidisciplinar, com psicoterapia, farmacoterapia, psicoeducação e suporte familiar (terapia familiar útil em adolescentes). **TCC é o padrão ouro**: interrompe o ciclo compulsão e purgação, modifica crenças sobre peso e imagem, regulariza a alimentação e reduz compensatórios; alternativas: interpessoal, analítica e em grupo.

Farmacoterapia: fluoxetina é o único aprovado pela FDA e reduz compulsão, purgação, impulsividade, ansiedade e depressão; há alguma evidência para sertralina, escitalopram e fluvoxamina, e menos para trazodona e topiramato. **Bupropiona é contraindicada na BN**, porque reduz o limiar convulsivo e os distúrbios hidroeletrolíticos da purgação aumentam ainda mais o risco de convulsão. Psicoterapia mais fármaco supera cada um isolado, e psicoterapia isolada supera fármaco isolado.

Diretrizes da APA: (1C) adultos com bulimia devem receber TCC focada e um inibidor da recaptação de serotonina, **por exemplo fluoxetina 60 mg por dia**, desde o início ou se houver resposta mínima ou ausente à psicoterapia após 6 semanas; (2C) adolescentes e adultos jovens com cuidador envolvido, terapia familiar focada.

Prescrição modelo de prova (bulimia em adulto): fluoxetina 20 mg, titulada até 60 mg por dia, associada a TCC focada em transtorno alimentar, com dosagem de potássio e ECG pela purgação. A dose de 60 mg vem da diretriz citada na aula; a titulação a partir de 20 mg segue a faixa de 20 a 80 mg descrita na Aula 3.

Aula 13. Dependências

Dependência é a perda progressiva do controle sobre o uso, com manutenção do consumo apesar das consequências, sustentada por um sistema de recompensa desregulado e por um córtex pré-frontal enfraquecido. O diagnóstico usa 11 critérios e a gravidade depende de quantos estão presentes; o manejo combina entrevista motivacional, estágios de mudança, internação quando necessária e redução de danos.

1. Padrões de uso

Padrão	Definição	Exemplo ou ponto chave
Experimental (uso na vida)	Pontual, "uma vez na vida", por curiosidade ou influência social	Sem repetição
Recreativo ou ocasional	Em festas e lazer, para socializar ou prazer momentâneo, sem buscar alívio de sofrimento	Não implica dependência
Frequente	Regular, ainda sem compulsão nem prejuízo importante	Possível estágio inicial; quanto mais frequente, mais investigar os motivos
Nocivo	Prejuízo físico, psíquico, social ou comportamental pelo efeito naquele contexto, **independentemente da quantidade**; não é overdose	Pouco álcool, dirigir e bater o carro
Abusivo	Prejuízo pelo **padrão** (quantidade, frequência) ou pela condição clínica, inclusive contraindicação formal	Gestante que bebe; cirrótico que continua bebendo
Binge	Grandes quantidades em curto intervalo, comum com álcool	Risco de intoxicação, acidentes, impulsividade

Macete: nocivo = Naquele contexto (efeito); abusivo = Abuso do padrão ou da condição clínica.

2. Conceitos fundamentais

- **Intoxicação:** sinais e sintomas pelo uso recente, variando com substância, dose, via, metabolismo e contexto. Algumas têm efeito **bifásico**: o álcool primeiro causa euforia e desinibição, depois sedação e lentificação.
- **Fissura:** desejo intenso e urgente, ligado à recompensa e principal fator de recaída. **Meia-vida curta gera mais fissura e dependência**, porque a concentração despenca logo após o uso (crack: início rápido e efeito curto).
- **Tolerância:** menor efeito com a mesma dose, exigindo doses maiores, por adaptação neurobiológica.
- **Abstinência:** sinais ao reduzir ou suspender o uso contínuo; irritabilidade, ansiedade, náuseas, tremores, sudorese, insônia, agitação.

Da busca de prazer ao alívio do sofrimento. No início a pessoa usa pelos efeitos prazerosos (euforia, relaxamento, desinibição). Com a tolerância, a mesma dose dá menos prazer, e o uso passa a servir para evitar o desconforto da privação e a abstinência. A substância ganha prioridade sobre trabalho, estudo, autocuidado e vínculos.

3. Critérios diagnósticos e gravidade

Giram em torno da importância que a substância assume, da perda de controle e do uso apesar das consequências. **Os 11 critérios, agrupados no mnemônico "4 C" (Controle, Compromissos sociais, Consequências de risco, Corpo farmacológico):**

Controle prejudicado:

1. Usa mais ou por mais tempo que o planejado.
2. Desejo persistente ou tentativas fracassadas de controlar.
3. Muito tempo para obter, usar ou se recuperar.
4. Fissura.

Compromissos sociais:

5. Fracasso em cumprir obrigações (trabalho, escola, casa).
6. Uso continuado apesar de problemas sociais ou interpessoais.
7. Abandono ou redução de atividades sociais, recreativas ou ocupacionais.

Consequências de risco:

8. Uso em situações de perigo físico (dirigir, operar máquinas).
9. Uso apesar de problemas físicos ou psíquicos causados ou agravados (álcool na cirrose, cocaína com ansiedade ou doença cardiovascular).

Corpo farmacológico:

10. Tolerância.
11. Abstinência.

Gravidade	Critérios
Leve	2 a 3
Moderada	4 a 5
Grave	6 ou mais

Macete "2, 4, 6": cada par de critérios sobe um degrau.

4. Etiologia: indivíduo, meio e substância

Indivíduo: fatores biológicos, psicológicos e psiquiátricos. Transtornos não tratados levam ao uso para aliviar sofrimento, ansiedade, impulsividade, insônia ou depressão; genética, personalidade, baixa tolerância à frustração e má regulação emocional aumentam a vulnerabilidade.

Meio: famílias disfuncionais, violência doméstica, privação afetiva, exclusão social e pobreza; **a situação de rua é um dos principais fatores de agravamento e manutenção.** Nas dependências comportamentais o meio age de formas distintas: nas apostas, a pobreza leva à busca de ganho rápido e o poder aquisitivo alto, à busca de adrenalina. Muitas vezes a substância ou o comportamento tenta preencher faltas emocionais.

Substância:

- **Tipo:** ação rápida e intensa na recompensa gera mais reforço.
- **Via de administração:** quanto mais rápido o cérebro percebe o efeito, maior o potencial aditivo. A via oral é lenta e enfraquece a associação imediata entre ato e recompensa (antidepressivos, lisdexanfetamina no TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). A via inalatória tem início extremamente rápido, pico intenso e efeito curto, favorecendo ciclos repetidos.
- **Quantidade:** doses maiores aumentam intoxicação, tolerância e dependência.
- **Meia-vida:** curta gera flutuação sérica, fissura e abstinência precoces (midazolam, BZD, benzodiazepínico, de ação curta, com mais risco de uso inadequado fora de ambiente supervisionado).

Macete "TV QM" da substância: Tipo, Via, Quantidade, Meia-vida.

Neurobiologia, psicologia e sociedade:

- **Genética:** genes ligados a álcool e cocaína, sobretudo os da transcrição e função dos receptores D2 (dopamina tipo 2), alteram a sensibilidade à liberação de dopamina e aumentam o reforço positivo após o uso.
- **Psicológicos:** dinâmica familiar, vínculos, violência, negligência, desempenho escolar; impulsividade, busca de novidade, abertura a experiências, baixa tolerância à frustração, instabilidade emocional e pouco controle inibitório.
- **Sociais:** risco com acesso fácil, exposição ao uso, vulnerabilidade socioeconômica, violência urbana e exclusão; proteção com rede de apoio familiar, inserção social, esporte e cultura, religiosidade e participação comunitária.
- **Comorbidades:** no TDAH, impulsividade e busca de novidade levam a experimentação precoce e risco particular de cocaína e estimulantes; na depressão, uso para aliviar tristeza, anedonia ou ansiedade, gerando dependência secundária.

5. O sistema de recompensa

Ideia central: a dopamina não gera prazer diretamente; ela sinaliza que um comportamento é relevante e merece ser repetido, e fornece a energia motivacional para executá-lo.

As três estruturas, com o exemplo da hamburgueria:

Estrutura	Função	No exemplo
Amígdala	"Pesa" o valor emocional do estímulo: recompensa ou ameaça	Com fome, sente o cheiro e marca como recompensador
Hipocampo	Memórias que ligam lugares, pessoas, cheiros e músicas à recompensa; disparam fissura	Lembra se aquele hambúrguer foi bom ou ruim
Córtex pré-frontal	Funções executivas: planejar, decidir, controlar impulsos, avaliar riscos, adiar recompensa	Pondera fome, prazer e prejuízo à saúde

Integração. O pré-frontal decide combinando o sinal emocional atual da amígdala com a memória do hipocampo: se a experiência passada foi ótima, tende a repetir; se foi ruim, desiste. **A dopamina é liberada no momento da decisão, antes da ação**, mobilizando energia para comer o hambúrguer ou para seguir outro caminho. No TDAH, a falha dopaminérgica impede atribuir valor a tarefas sem recompensa imediata (procrastinação, dificuldade de iniciar), até que a urgência, como uma prova próxima, aumente o valor e a ativação.

Erro de previsão de recompensa. Depois da ação o cérebro compara o esperado com o recebido:

- Recebeu **mais** que o esperado: segundo pico de dopamina, registro de que "valeu a pena", maior chance de repetir.
- Recebeu **igual**: sem alteração relevante.
- Recebeu **menos**: dopamina cai abaixo do basal, o cérebro marca como desvantajoso e reduz a repetição.

Macete "Mais = Marca; Menos = Murcha".

Maturação cerebral. Na adolescência o pré-frontal ainda está imaturo, enquanto o sistema de recompensa é mais reativo: mais impulsividade, busca de novidade, comportamentos de risco, dificuldade de avaliar consequências e influência dos pares. Por isso é o período de maior vulnerabilidade à experimentação e à dependência. **Macete: "acelerador pronto, freio em construção".**

Recompensa na dependência. O cérebro perde a capacidade de atribuir valor correto às recompensas; as imediatas passam a valer muito mais que as de longo prazo, e o paciente prioriza alívio rápido apesar de prejuízos físicos, familiares, sociais, financeiros e ocupacionais. O "quando vi já estava indo comprar" esconde uma cadeia de decisões (pensou, decidiu sair, vestiu-se, planejou o trajeto, foi ao local) movida por circuitos de motivação hiperativos e por um pré-frontal que não freia.

6. Classes de substâncias psicoativas

Classe	Efeito	Exemplos	Ponto chave
Depressores do SNC (Sistema Nervoso Central)	Lentificação, sedação, menor alerta	Álcool, opioides (heroína, morfina), solventes e inalantes (cola, loló, lança-perfume), benzodiazepínicos	Efeito bifásico no álcool e nos solventes
Perturbadores (psicodislépticos, alucinógenos)	Alteram percepção da realidade, emoções, tempo e estímulos	Maconha, cogumelos, LSD (dietilamida do ácido lisérgico)	Na maconha, tudo parece mais engraçado e o tempo passa diferente
Estimulantes	Aumentam a atividade cerebral e a dopamina na recompensa	Cocaína, crack, anfetaminas, psicoestimulantes	Liberação dopaminérgica artificial e intensa

Mecanismo do efeito bifásico. Em dose baixa, o depressor inibe primeiro as áreas que fazem o controle e a inibição do comportamento; ao "frear o freio", surgem desinibição, euforia, mais fala e sociabilidade. Em dose maior, as demais áreas também são deprimidas: sedação, sonolência, lentificação e rebaixamento da consciência.

Por que os estimulantes viciam tanto. Normalmente a dopamina sobe quando a recompensa supera a expectativa, ensinando o cérebro a repetir. O estimulante produz esse sinal de forma artificial e intensa, sem conquista real: além do prazer, grava com força no circuito de aprendizado que usar a droga é prioritário, até o consumo ser interpretado como necessidade.

Macete das classes: "DPE" = Desacelera, Perturba, Estimula.

7. Dependências comportamentais

Redes sociais, jogos eletrônicos, apostas, pornografia e vídeos curtos também ativam a recompensa. O sistema funciona de forma saudável com **recompensa intermitente**, após esforço, espera ou conquista (estudar e tirar boa nota, treinar e melhorar, trabalhar e receber). O ambiente digital oferece **recompensa rápida, contínua e fácil** (notificações, curtidas, conteúdo infinito), a chamada "dopamina barata": não porque a dopamina seja boa ou ruim, mas pela recompensa com esforço mínimo e alta frequência. Com o tempo cai a tolerância ao tédio e à espera e a capacidade de sustentar esforço com recompensa tardia; em alguns, surgem perda de controle, compulsão, dificuldade de parar, prejuízo e persistência apesar das consequências.

8. Reforço positivo e negativo

Aspecto	Reforço positivo	Reforço negativo
Fase	Inicial	Avançada
Motivação	Buscar prazer	Evitar sofrimento: "uso para não me sentir mal"
Traço predominante	Impulsividade	Compulsividade
Ciclo	Antecipação, consumo excessivo ou intoxicação, prazer, depois abstinência	Preocupação, busca compulsiva, intoxicação, abstinência com afeto negativo
Marcadores	Binge e intoxicação, por aumento artificial de dopamina	Ansiedade, irritabilidade, disforia, angústia, agitação, vazio

Macete: a dependência vai do "I" ao "C": Impulsiva (positivo) para Compulsiva (negativo).

9. Estágios de mudança

O paciente pode transitar várias vezes entre eles. **Mnemônico "PCPAMRT", lido como "Pra Começar Preciso Agir, Manter, Recair e Terminar"**:

1. **Pré-contemplação:** não reconhece o problema ("uso pouco", "paro quando quiser", "exageram"); baixa motivação.
2. **Contemplação:** percebe o problema e as consequências, mas está ambivalente; deseja mudar e continuar usando.
3. **Preparação:** planeja mudanças concretas; momento ótimo para intervir.

4. **Ação:** muda de fato (para, busca tratamento, muda rotina, afasta-se de ambientes de risco, faz psicoterapia ou grupos); grande esforço.
5. **Manutenção:** sustenta a mudança e previne recaída; "abstinência" aqui significa não usar, não síndrome física; aprende a lidar com fissura e gatilhos.
6. **Recaída:** frequente e **não é fracasso absoluto**, porque o aprendizado da recompensa persiste; ajuda a identificar gatilhos, contextos e dificuldades. Em geral volta à contemplação, às vezes à pré-contemplação.
7. **Término:** a substância deixa de ser central; o desejo pode aparecer sem sofrimento nem busca compulsiva. A pessoa não "deixa de ser dependente" (o risco persiste), mas está fora do ciclo ativo.

10. Entrevista motivacional

Pode ser usada por qualquer profissional e em qualquer fase, inclusive com pacientes pouco motivados. Objetivo: aumentar a motivação e o compromisso com a mudança e ajudar o paciente a reconhecer problemas. Postura centrada no paciente, flexível, cooperativa, evocativa (retoma o que o paciente diz) e **diretiva sem ser autoritária nem confrontativa**, com alta tolerância à frustração.

Os 5 pilares, mnemônico "EDEAP" ("Empatia Desenvolve, Evita Atrito, Potencializa"):

1. **Expressar empatia:** acolher o ponto de vista sem concordar nem incentivar o uso.
2. **Desenvolver discrepância:** mostrar a distância entre o comportamento atual e os valores e metas do próprio paciente.
3. **Evitar argumentação:** confronto aumenta resistência; estimular reflexão e autonomia em vez de convencer.
4. **Acompanhar a resistência:** ambivalência é normal; acompanhar o raciocínio e oferecer novas perspectivas aos poucos.
5. **Promover autoeficácia:** reforçar conquistas e a crença na capacidade de mudar.

11. Internação e redução de danos

Internação. Funciona melhor quando **voluntária**, porque exige motivação e adesão. A involuntária protege a vida e a integridade quando há risco iminente de morte, risco grave de auto ou heteroagressão, comprometimento importante do julgamento e do autocuidado, ou determinação judicial em situações específicas. Mesmo iniciada de forma involuntária, deve-se tentar convertê-la em voluntária. **Jamais é punição, castigo familiar ou medida disciplinar.**

Redução de danos. Diminui prejuízos físicos, psíquicos e sociais mesmo sem interromper o uso; o foco é reduzir dano, não necessariamente impedir o consumo. **Não se opõe à abstinência**: pode ser etapa intermediária rumo a ela. É individualizada, sem julgamento

moral, "ajudando a pessoa como ela consegue ser ajudada", sobretudo quem não quer, não consegue ou tem pouca motivação para parar. Estratégias: orientações de uso mais seguro, prevenção de infecções, redução de comportamentos de risco, acompanhamento multiprofissional e fortalecimento do vínculo com os serviços.

Revisão final: quadros comparativos e pontos de prova

Esta seção reúne, em formato de consulta rápida, os números, fármacos e contrastes que atravessam várias aulas. Use-a na terceira passada de estudo, tentando lembrar cada linha antes de ler.

1. Régua dos tempos diagnósticos

Quadro	Tempo mínimo	Aula
Hipomania	4 dias	4
Mania	7 dias (ou qualquer, se internar)	4
Episódio depressivo maior	2 semanas	3 e 4
Esquizoafetivo: psicose sem humor	2 semanas	6
Psicótico breve	Menos de 1 mês	6
Transtorno delirante	1 mês	6
Pânico: apreensão ou mudança após ataque	1 mês	7
Transtorno de adaptação	Início em até 3 meses; some em até 6 meses após o estressor	9
Compulsão alimentar e bulimia	1 vez por semana por 3 meses	12
Esquizofreniforme	1 a menos de 6 meses	6
Esquizofrenia, TAG, agorafobia, fobia específica, ansiedade de doença	6 meses	6, 7, 10
Luto prolongado	12 meses em adultos; 6 em crianças e adolescentes	9
Tourette e tique persistente	Mais de 1 ano, início antes dos 18	8
Distimia e ciclotimia	2 anos, sem passar mais de 2 meses assintomático	3 e 4

2. Quadro mestre dos psicofármacos

Classe	Mecanismo	Indicações nas aulas	Efeitos e cuidados principais
ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina)	Bloqueiam o SERT (transportador de serotonina); dessensibilizam autorreceptores em 6 a 8 semanas	Depressão, TAG, pânico, ansiedade social, TOC (dose alta, 12 a 20 semanas), TEPT, bulimia (fluoxetina), somatoformes, despersonalização, evitativo	Hiponatremia, QTc, sangramento, embotamento, disfunção sexual, interações (fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina)
IRSN (Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina)	Recaptação de serotonina e noradrenalina (venlafaxina dual só a partir de cerca de 150 mg)	Depressão com pouco afeto positivo, dor (duloxetina), fogachos (desvenlafaxina), TAG, pânico (venlafaxina)	Síndrome de retirada, hipertensão, sudorese; não aprovados no TOC
ADT (Antidepressivos Tricíclicos)	Recaptação de serotonina e noradrenalina	Depressão (75 mg ou mais), dor, enxaqueca, enurese, TOC (clomipramina), pânico (imipramina, clomipramina)	Arritmia e QTc, limiar convulsivo, CYP450, anticolinérgico no idoso
Bupropiona	Recaptação de dopamina e noradrenalina	Depressão, tabagismo, compulsão alimentar	Quase sem disfunção sexual; **contraindicada na bulimia** (convulsão)
Mirtazapina	Antagonista alfa 2	Depressão, insônia	Sonolência, ganho de peso
Lítio	Mecanismo não totalmente elucidado; neuroprotetor	TAB em todas as fases, potencialização na depressão, antissuicídio	Litemia (1,0 mEq/L na mania), TSH, creatinina, cálcio; diuréticos, AINE e IECA elevam o nível; diabetes insípido

Classe	Mecanismo	Indicações nas aulas	Efeitos e cuidados principais
Lamotrigina	Anticonvulsivante, modula glutamato	Depressão bipolar; adjuvante em TOC refratário e despersonalização	Titulação lenta (25 mg a cada 2 semanas); rash; nunca com valproato
Valproato	Anticonvulsivante	Mania, ciclagem rápida, estados mistos; agressividade no antissocial	Gastrite, rash, teratogênico
Antipsicóticos típicos	Antagonismo D2	Psicose; haloperidol IM na agitação e depósito	Extrapiramidais (alta potência); sedação, hipotensão e efeito anticolinérgico (baixa potência)
Antipsicóticos atípicos	D2 mais 5-HT2A; aripiprazol e brexpiprazol agonistas parciais	Esquizofrenia, TAB, potencialização da depressão e do TOC, delirium, demência, anorexia (olanzapina)	Síndrome metabólica, prolactina, QTc; acatisia (aripiprazol); agranulocitose (clozapina)
Benzodiazepínicos	Modulam alostericamente o GABA-A, aumentando a abertura do canal de cloro	Crises de pânico no início ou resgate, insônia breve, convulsão e abstinência alcoólica (diazepam)	Dependência, quedas, depressão respiratória; **evitar no 1º mês pós trauma e no borderline**
Pregabalina	Liga α2δ dos canais de cálcio, reduz glutamato, noradrenalina e substância P	TAG, pânico sem depressão, resposta parcial ao ISRS	Tontura, sonolência, quedas, edema; ajuste renal
Buspirona	Agonista parcial 5-HT1A	TAG, adjuvante, bruxismo por ISRS	Latência de semanas; ineficaz no pânico

Classe	Mecanismo	Indicações nas aulas	Efeitos e cuidados principais
Lisdexanfetamina	Modula recompensa e controle inibitório	Único aprovado pela FDA para compulsão alimentar	Não é para emagrecer sem TCAP
Escetamina	Antagonista NMDA, glutamato e AMPA, mais BDNF	Depressão resistente, alto risco de suicídio	Dose subanestésica, ambiente controlado, sempre com antidepressivo
Doxazosina, prazosina e propranolol	Bloqueio alfa 1 ou beta adrenérgico	TEPT e estresse agudo: pesadelos e intrusivos (alfa), hiper-reatividade (beta)	Prazosina indisponível no Brasil

3. As "únicas aprovações" e as "proibições" que mais caem

- **Fluoxetina:** única aprovada pela FDA para bulimia; APA cita 60 mg por dia.
- **Lisdexanfetamina:** única aprovada pela FDA para compulsão alimentar.
- **Lamotrigina:** aprovada só para depressão bipolar.
- **Lítio e quetiapina:** padrão ouro aprovados para todas as fases do TAB.
- **Clozapina:** esquizofrenia refratária após 2 antipsicóticos; hemograma "18 e 18".
- **Nunca:** bupropiona na bulimia; lamotrigina com valproato; BZD no primeiro mês após trauma; BZD no borderline; valproato em mulher fértil sem controle; antidepressivo de manutenção no TAB.

4. Os pares de diagnóstico diferencial mais cobrados

Par	Critério que separa
Alerta x lúcido	Acordado e responde x pensa com clareza
Alucinação x ilusão x alucinose	Sem objeto x objeto distorcido x sem objeto, com crítica (orgânico)
Ideia sobrevalorada x delírio	Algum vínculo com a realidade x certeza irremovível
Impulso x compulsão	Busca prazer imediato x alivia ansiedade

Par	Critério que separa
TAB x borderline	Episódios de dias a semanas, sem gatilho x horas, reativo a abandono
TAB x TDAH	Episódico, menos necessidade de sono x contínuo desde a infância, precisa dormir
Esquizoafetivo x humor psicótico	Psicose isolada por 2 semanas x psicose só dentro do episódio
Esquizofrenia x transtorno delirante	Queda global x prejuízo restrito ao tema do delírio
Esquizoide x TEA	Desinteresse genuíno x deseja interagir, mas tem dificuldade
Narcisista x antissocial	Quer admiração x quer vantagem
Borderline x dependente	Medo de não ser amado x medo de não funcionar sem cuidado
Sintomas somáticos x ansiedade de doença	O sintoma preocupa x a doença possível apavora
Conversivo x factício x simulação	Involuntário x intencional sem ganho externo x intencional com ganho
Retirada x recaída	Dias após parar x semanas, com volta dos sintomas originais
Uso nocivo x abusivo	Dano pelo efeito no contexto x dano pelo padrão ou condição clínica
AN x BN	"Não comer" e peso baixo x ciclo compulsão e compensação, peso normal
Vômito x laxante	Alcalose metabólica x acidose metabólica

5. Números de alto rendimento

Dado	Valor
Herdabilidade da depressão	37%
Deprimidos que são bipolares	12,5% a 30%
Risco de suicídio no TAB	Até 15 vezes

Dado	Valor
Suicídio com transtorno mental	90% dos casos, risco cerca de 8 vezes
Envenenamento por pesticida entre suicídios	Cerca de 20%
Esquizofrenia: TAE e suicídio consumado	25% a 50% e cerca de 10%
Transtorno delirante: prevalência	Cerca de 0,2%
TOC: prevalência, atraso, comorbidade	1% a 3%; 17 anos; até 90%
TOC: ideação, plano, tentativa	36%, 20%, 11%
Antissocial: geral e forense	0,6% a 3,6% e até 70%
Conversivo	1 em 10.000; 4% da neurologia; 90% com comorbidade; 10% com epilepsia
Anorexia: herdabilidade e complicação cardíaca	50% a 60%; até 80%
ECT: queda da ideação suicida	38% em 1 semana, 61% em 2, 81% ao final
Exposição prolongada no TEPT: abandono	30% a 35%
TAG: recaída com e sem manutenção	Cerca de 20% e 50%
Fissura alimentar	Dura cerca de 20 minutos
Realimentação	Início 5 a 20 kcal/kg/dia; síndrome por volta do 4º dia

6. Os princípios que atravessam todo o curso

1. **Diagnóstico é clínico**, pelo EEM (Exame do Estado Mental) e pelos critérios do DSM-5-TR, sempre excluindo causa orgânica quando o quadro sugere (delirium, pânico no pronto atendimento, conversivo, amnésia dissociativa).
2. **Reforço negativo** sustenta TOC, dependência, escoriação e evitações ansiosas; por isso a exposição sem ritual, sem esquiva e sem substância é o eixo terapêutico.
3. **Psicoterapia é primeira linha** em ansiedade leve, fobia específica, TEPT, personalidade, somatoformes, dissociativos e transtornos alimentares; fármacos tratam sintomas e comorbidades.
4. **Psicoeducação sem invalidar** o sofrimento, com envolvimento da família e atenção à acomodação familiar.

5. **Perguntar sobre suicídio sempre**, notificar a tentativa no SINAN e lembrar do lítio, da ECT e da escetamina como armas antissuicídio.

Fontes: apostilas das Aulas 1 a 13 da pasta Psiquiatria (Mariana Freitas, turma 79A), que seguem o DSM-5-TR e citam as diretrizes da APA e a CID-11.